NTS Nº 238 -MINSA/DGIESP-2025

NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO

I. FINALIDAD

Contribuir a mejorar el estado de salud, nutrición y desarrollo del niño de 0 hasta los 11 años, 11 meses y 29 días.

II. OBJETIVO

Establecer las disposiciones técnicas y administrativas para el control de crecimiento y desarrollo del niño de 0 hasta los 11 años, 11 meses y 29 días.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Norma Técnica de Salud es de aplicación y cumplimiento obligatorio en todos los establecimientos de salud públicos, privados y mixtos que, dentro de su cartera de servicios, incorporan el control de crecimiento y desarrollo de niños, así como para el Ministerio de Salud, las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS), las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), Gerencias Regionales de Salud (GERESA) o las que hagan sus veces a nivel regional, el Seguro Social de Salud (EsSalud), y las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

IV. BASE LEGAL

- Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.
- Código de los Niños y Adolescentes.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y sus modificatorias.
- Ley N° 29885, Ley del Tamizaje Neonatal Universal, y su modificatoria.
- Ley Nº 30150, Ley de protección de las personas con trastorno del espectro autista (TEA).
- Ley Nº 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud (RIS).
- Ley Nº 30421, Ley Marco de Telesalud, y sus modificatorias.
- Ley Nº 30947, Ley de Salud Mental, y su modificatoria.
- Ley Nº 31041, Ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención integral del cáncer del niño y del adolescente.
- Ley Nº 31189, Ley para fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas.
- Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 020-2014-SA, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo Nº 009-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Alimentación Infantil.
- Decreto Supremo N° 008-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo Nº 001-2015-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30150, Ley de Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
- Decreto Supremo N° 016-2016–SA, que aprueba la Política Sectorial de Salud Intercultural.

- Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 007-2020-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30947, Ley de Salud Mental, y su modificatoria.
- Decreto Supremo N° 005-2021-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30421, Ley Marco de Telesalud, y del Decreto Legislativo N° 1490, Decreto Legislativo que fortalece los alcances de la Telesalud.
- Decreto Supremo Nº 008-2021-MIMP, que aprueba la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030.
- Decreto Supremo Nº 023-2021-SA, que aprueba la actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), y su modificatoria.
- Decreto Supremo N° 024-2021-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31041, Ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención integral del cáncer del niño y del adolescente.
- Decreto Supremo N° 008-2022-MIDIS, que aprueba la Política Nacional Multisectorial de Desarrollo e Inclusión Social al 2030.
- Decreto Supremo N° 095-2022-PCM, que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, y su modificatoria.
- Decreto Supremo Nº 002-2024-SA, que aprueba el Plan Multisectorial para la Prevención y Reducción de la Anemia Materno Infantil en el Perú. Periodo 2024-2030.
- Decreto Supremo N° 019-2024-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud – RIS.
- Resolución Suprema Nº 023-2019-EF, que aprueba el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano
- Resolución Ministerial Nº 751-2004/MINSA, que aprueba la NT Nº 018-MINSA/DGSP-V01, Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud.
- Resolución Ministerial Nº 292-2006/MINSA, que aprueba la NTS N° 040-MINSA/DGSP-V.01, Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de la Niña y el Niño, y su modificatoria.
- Resolución Ministerial N° 1353-2018/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Guías Alimentarias para la Población Peruana.
- .
- Resolución Ministerial Nº 030-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad (MCI).
- Resolución Ministerial N° 967-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Guías Alimentarias para niñas y niños menores de 2 años de edad.
- Resolución Ministerial Nº 884-2022/MINSA, que aprueba la NTS N° 196-MINSA/DGIESP-2022, Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación, y sus modificatorias.
- Resolución Ministerial N° 034-2024/MINSA, que aprueba la Guía Técnica para la Valoración Nutricional Antropométrica de la Niña y el Niño de 0 a 11 Años.
- Resolución Ministerial Nº 545-2024/MINSA, que aprueba la NTS Nº 214-MINSA/DGIESP-2024, Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Neonatal.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 Definiciones Operativas

- **Crecimiento:** Proceso de incremento de la masa corporal de un ser vivo, que se produce por el aumento en el número de células (hiperplasia) o de su tamaño (hipertrofia). Es un proceso que está regulado por factores nutricionales, socioeconómicos, culturales, emocionales, genéticos y neuroendocrinos. Se mide por medio de las variables antropométricas: Peso, talla y perímetro cefálico, entre otros.

- **Consejería:** Proceso educativo y comunicacional, concebido como un diálogo participativo, que facilita a la madre, padre o cuidador principal la comprensión de los factores que influyen en la salud, nutrición y desarrollo del niño, identificados durante la valoración. Permite la identificación conjunta de alternativas y la toma de decisión para el establecimiento de acuerdos y compromisos.

- **Curva de crecimiento:** Representación gráfica de la unión de los puntos marcados durante los controles de crecimiento y desarrollo (CRED), que muestra el historial de crecimiento del niño a lo largo del tiempo.

- **Desarrollo:** Proceso dinámico por el cual los seres vivos logran progresivamente hacer efectiva la capacidad funcional de sus sistemas a través de fenómenos de maduración, diferenciación e integración de sus funciones, en aspectos como el biológico, psicológico, cognoscitivo, nutricional, sexual, ecológico, cultural, ético y social. Se encuentra influenciado por factores genéticos, culturales y ambientales.

- **Desnutrición:** Se refiere a deficiencias o excesos en la ingesta de nutrientes, desequilibrio de nutrientes esenciales o alteración de la utilización de nutrientes. Incluye la emaciación (un peso insuficiente respecto de la talla), el retraso del crecimiento (una talla insuficiente para la edad) y la insuficiencia ponderal (un peso insuficiente para la edad).

- **Detección de trastornos mentales y problemas psicosociales:** Es el proceso de identificación temprana de condiciones de salud mental y problemas psicosociales en niñas, niños y adolescentes, de 0 a 11 años, 11 meses y 29 días. Esta detección también incluye a las madres, padres o cuidadores principales, y el entorno directo e indirecto del niño, para identificar factores de riesgo, como violencia intrafamiliar, depresión en los cuidadores principales, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, trastornos del neurodesarrollo (ej. Trastorno del Espectro Autista), o eventos adversos, entre otros, a través de la administración de uno o más instrumentos validados.

- **Discapacidad**: Término genérico que incluye las deficiencias de funciones y/o estructuras corporales, limitaciones en las actividades y restricciones en la participación, indicando los aspectos negativos de la interacción de un individuo (con una condición de salud) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales).

- **Enfoque intercultural:** Valoración e incorporación de las diferentes perspectivas culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales para la generación de servicios con pertinencia cultural, promoviendo el reconocimiento de una ciudadanía intercultural multilingüística, y un diálogo horizontal y empático.

- **Esquema de vacunación:** Es la representación cronológica y secuencial para la administración de las vacunas aprobadas oficialmente para el país, como parte de la política nacional de vacunación e inmunización, según edad de los niños/niñas.

- **Estatura:** Es la medida que se toma a niñas y niños de 2 años a más, en posición vertical, desde el vértice de la cabeza hasta los talones.

- **Factores de protección para el crecimiento y desarrollo**: Actitudes, conductas, circunstancias individuales y colectivas, que se van conformando en un medio social y que incluyen aspectos relacionados con la salud, educación, vivienda, afectos y comportamientos saludables, que favorecen el crecimiento y desarrollo del niño.

- **Factores de riesgo para el crecimiento y desarrollo**: Característica, circunstancia o situación detectable que aumenta la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a una condición o fenómeno de interacción negativo para el crecimiento y desarrollo del niño. Los factores de riesgo pueden clasificarse como:

    - Biológicos (endógeno): Abarcan condiciones del periodo prenatal, perinatal y postnatal (ej. bajo peso, prematuridad, malformaciones congénitas, edad, etc.).

    - Sociales (exógeno): Condiciones sociales negativas que alteran el proceso madurativo (ej. falta de cuidados o interacciones adecuadas, maltrato, negligencia, abusos, etc.).

    - Ambiental (exógeno): Contaminación del aire, agua y suelo, exposición a productos o sustancias químicas, cambio climático y radiación ultravioleta, entre otros.

- **Índice de masa corporal (IMC):** Indicador que determina la relación entre la masa corporal de una persona y su estatura, que se calcula dividiendo los kilogramos de peso por el cuadrado de la estatura en metros (IMC = peso [kg]/ estatura [m^2]).

- **Longitud:** Medida que se toma a niñas y niños menores de 2 años en posición horizontal, desde el vértice de la cabeza hasta los talones.

- **Macrocefalia:** Condición en la que el perímetro cefálico de una niña o niño es significativamente mayor que el esperado para su edad y sexo. Para efectos de la presente Norma Técnica de Salud, se define operativamente como una medida del perímetro cefálico que se encuentra por encima de dos (+2) desviaciones estándar de la mediana o mayor del percentil 97 de los Patrones de Crecimiento Infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

- **Malnutrición:** Se refiere a las carencias, los excesos y los desequilibrios de la ingesta calórica o de nutrientes de una persona. Abarca tres grandes grupos de afecciones: La desnutrición, la malnutrición relacionada con los micronutrientes, que incluye las carencias de micronutrientes o su exceso, y el sobrepeso o la obesidad.

- **Microcefalia:** Condición en la que el perímetro cefálico de una niña o niño es significativamente menor que el esperado para su edad y sexo. Para efectos de la presente Norma Técnica de Salud, se define operativamente como una medida del perímetro cefálico que se encuentra por debajo de dos (-2) desviaciones estándar de la mediana o menor a percentil 3 de los Patrones de Crecimiento Infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

- **Perímetro cefálico:** Medida antropométrica de la circunferencia de la cabeza en su parte más amplia (por encima de cejas y orejas, y alrededor de la parte posterior más prominente). Este parámetro permite la identificación de posibles alteraciones en el crecimiento cerebral.

- **Peso:** Medida antropométrica que determina la masa corporal de una persona, expresada en kilogramos.

- **Regresión en el desarrollo:** Condición caracterizada por la pérdida de habilidades previamente adquiridas, como caminar, hablar, o la pérdida de habilidades sociales. Por ejemplo: Un niño que ha estado caminando deja de caminar, o un niño que ha estado

hablando deja de hablar. Esta pérdida puede ser total o parcial, y puede ocurrir de forma repentina o gradual.

- **Riesgo**: Incremento de la probabilidad que tiene un niño de padecer un daño a la salud debido a la presencia de un factor.

- **Señales de alarma:** Expresión clínica de un probable retraso o desviación del patrón normal de desarrollo. Estos signos no son evidencia absoluta de un retraso neurológico o del desarrollo, sino que indican que es necesaria una interconsulta o derivación. Corresponde a uno de los ejes de la prueba "Evaluación del Desarrollo Infantil".

- **Señales de alerta:** Conjunto de signos o síntomas que, en ausencia de otra alteración, pueden sugerir una desviación del patrón normal de desarrollo. Corresponde a uno de los ejes de la prueba "Evaluación del Desarrollo Infantil". Su presencia indica la necesidad de un seguimiento más cercano del desarrollo del niño.

- **Servicios de salud con pertinencia cultural:** Servicios que incorporan el enfoque intercultural en su gestión y prestación. Adaptan sus procesos a las características geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales (prácticas, valores y creencias) de sus usuarios.

- **Talla:** Medida antropométrica de la longitud o estatura de la persona, determinada según la edad.

- **Tamizaje del desarrollo:** Proceso para la detección precoz de posibles desviaciones en el desarrollo del niño, mediante la aplicación de un instrumento estandarizado, validado y breve, que permite la identificación del cumplimiento de hitos del desarrollo de acuerdo a la edad. No establece un diagnóstico.

- **Tamizaje visual:** Proceso para la detección precoz de posibles problemas o deficiencias visuales en el niño. Se realiza desde el nacimiento y de manera periódica, incluso en ausencia de molestias o patologías.

- **Tendencia del crecimiento:** Dirección o patrón de la trayectoria que la curva de crecimiento sigue entre puntos de medición.

- **Valoración nutricional antropométrica:** Proceso que permite la determinación del estado nutricional de la niña y niño, efectuada mediante la medición de variables antropométricas como el peso, longitud/estatura y perímetro, según corresponda con la edad y sexo. Cada niño tiene su propia velocidad de crecimiento.

- **Vigilancia del desarrollo en niños:** Proceso continuo y sistemático de seguimiento del progreso de un niño en áreas del desarrollo motor, el lenguaje, las habilidades socioemocionales y las habilidades cognitivas. Implica observar, documentar y analizar el desarrollo a lo largo del tiempo, utilizando la observación directa, la información de los padres y/o la aplicación de un instrumento, para la detección temprana de posibles problemas o desviaciones

5.2 ACRÓNIMOS

Para efectos de la presente Norma Técnica de Salud se utilizan los siguientes acrónimos;

- APNOP: Acciones presupuestarias que no Resultan en productos.
- ATD: Atención Temprana del Desarrollo.

- AUDIT-C: Cuestionario de identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol.
- CRED: Crecimiento y desarrollo.
- DDC: Displasia del desarrollo de cadera.
- DGIESP: Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública.
- EDI: Evaluación del desarrollo infantil.
- M-CHAT-R/F: Lista de verificación modificada para el autismo en niños pequeños (Modified Checklist for Autism in Toddlers) - Revisado y de seguimiento.
- PEAS: Plan Esencial de Aseguramiento en Salud.
- PHQ-9: Escala de salud del paciente-9.
- PPoR: Programa(s) Presupuestal(es) orientado(s) a resultados.
- PSC: Lista de síntomas pediátricos.
- PPSC: Lista de síntomas pediátricos para niños en edad preescolar.
- TEA: Trastorno de espectro autista.
- UE: Unidad Ejecutora.

5.3 La población objetivo para el control de crecimiento y desarrollo (CRED) es todo niño de cero hasta los 11 años, 11 meses y 29 días.

5.4 El control de CRED se refiere al conjunto de actividades periódicas y secuenciales realizado por el licenciado en enfermería o médico cirujano, con el objetivo de vigilar el crecimiento y desarrollo, detectar riesgos y alteraciones de forma oportuna, e implementar intervenciones para el cuidado integral del niño.

5.5 El control de CRED se brinda de forma ininterrumpida en todo establecimiento de salud público, privado o mixto que lo oferte en su cartera de servicios, garantizando una atención individual, integral, oportuna y ajustada a las necesidades del niño y a las necesidades de la población.

5.6 El control de CRED comprende cuatro procesos secuenciales: Valoración, diagnóstico, intervención y seguimiento. El proceso se inicia con la valoración integral para la detección de riesgos o alteraciones. La identificación de cualquier hallazgo obliga al profesional de la salud a establecer un diagnóstico y ejecutar la intervención y el seguimiento continuo, a fin de mejorar las prácticas de cuidado, alimentación y crianza de la familia (ver Anexo N° 1).

5.7 El profesional de la salud que realiza el control de CRED reconoce al niño como sujeto de derecho, lo que implica proteger su integridad, dignidad y bienestar físico y emocional. Esto incluye la presencia permanente de la madre, padre o cuidador principal, un trato amable y respetuoso para el niño y su acompañante, y un ambiente que asegure su seguridad, privacidad y confort.

5.8 Durante el control de CRED el profesional de la salud establece una comunicación empática y efectiva, usando lenguas originarias o a través de un traductor, de corresponder, respeta las características culturales del entorno familiar del niño y toma en cuenta las prácticas de crianza tradicionales. Durante la consejería, adecúa el ambiente y los horarios para facilitar el acceso con especial atención a los pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes, considerando las pautas descritas en el Anexo N° 2.

5.9 Las Unidades Ejecutoras (UE) con establecimientos de salud que, en su cartera de servicios, incluyan el control de CRED, son las responsables de la gestión administrativa y financiera de los recursos que garanticen los bienes y servicios necesarios para el control de CRED (recursos humanos, infraestructura, equipos, mobiliario e insumos), según el Anexo N° 3 de la presente Norma Técnica de Salud.

5.10 La Libreta de Cuidado Integral de Salud de la Niña y del Niño, física o digital, se trata del documento oficial y de uso obligatorio que es entregado a la madre, padre o cuidador principal del niño en cada establecimiento de salud en el primer control de manera gratuita. Su estructura y contenido se detalla en el Anexo N° 4.

5.11 El profesional de la salud que realiza el control de CRED es responsable del registro adecuado, completo e inmediato de la información en los siguientes instrumentos:

- Historia Clínica (física o digital).
- Libreta de Cuidado Integral de Salud de la Niña y del Niño (física o digital).
- Registro diario de atención, físico o digital (HIS-MINSA o sistemas de información utilizados por otras instituciones).
- Registros de seguimiento (físicos o digitales).
- Registro de acuerdo al sistema de aseguramiento que garantice el financiamiento, físico o digital, de corresponder (Ficha Única de Atención (FUA) u otros utilizados por cada institución administradora de fondos de aseguramiento en salud (IAFAS)).

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1. El control de CRED se realiza a través de oferta fija y móvil:

- La modalidad fija se realiza en los establecimientos de salud.
- La modalidad móvil se realiza a través de brigadas, en instituciones o espacios de la comunidad (cunas, instituciones educativas, Centros de Acogida Residencial (CAR), centros penitenciarios, centros de vigilancia comunal, entre otros), que garanticen las condiciones mínimas de privacidad, seguridad e higiene (acceso a lavado de manos), así como mobiliario básico (mesa y sillas) para la atención. Para esta modalidad, y en ausencia de la madre, padre o cuidador principal, es necesario contar, previamente a la realización de control de CRED, con la autorización de los mismos.

6.2. El tiempo promedio para el control de CRED es de 30 minutos. Sin embargo, este tiempo se extiende para garantizar la calidad, especialmente en las siguientes situaciones:

a. Según las necesidades particulares y los hallazgos identificados en el niño durante la valoración.
b. En las edades en las que, según lo establecido en la presente Norma Técnica de Salud, corresponda la aplicación de la prueba para el tamizaje del desarrollo.

6.3. En relación a los intervalos entre controles, éste se considera a partir de la fecha del último control de CRED realizado, y no en función de la edad cronológica del niño.

6.4. La frecuencia y número de control de CRED se detalla a continuación:

a. Recién nacido (0 a 28 días): Tres (03) controles de CRED:

- Primer Control: Antes de los 7 días de vida, cuando el parto es institucional, a partir de las 48 horas posteriores al alta del recién nacido, y cuando el parto **no** es institucional (domiciliario u otros), a partir de la notificación/conocimiento del nacimiento.

  Este primer control puede efectuarse en el establecimiento de salud o en el domicilio del recién nacido. En caso de realizarse el control en el domicilio, el profesional de la salud utiliza las pautas descritas en el Anexo N° 5.

- Segundo Control: Entre los 7 y 14 días de vida, realizado en el establecimiento de salud.

- Tercer Control: Entre los 14 y 21 días de vida, realizado en el establecimiento de salud.

- El intervalo mínimo entre controles es de siete (07) días.

b. **Niños de 29 días hasta los 11 meses y 29 días:** siete (07) controles, de **acuerdo** al siguiente detalle:

N° controles	Edad	Frecuencia/Intervalo entre control
1° control	1 mes (29 a 59 días)	Mensual Intervalo mínimo de 30 días
2° control	2 meses (60 a 89 días)	
3° control	3 meses (90 a 119 días)	
4° control	4 meses (120 a 149 días)	Bimensual Intervalo mínimo de 60 días
5 ° control	6 meses (180 a 209 días)	Mensual Intervalo mínimo de 30 días
6° control	7 meses (210 a 239 días)	Bimensual Intervalo mínimo de 60 días
7° control	**9 meses (270 a 299 días)**	**Último control de este grupo de edad**

c. **Niños 01 año (12 meses) hasta los 04 años, 11 meses y 29 días:** Para este grupo de edad, la periodicidad de controles se diferencia por año de edad.

Para el niño de un año se establecen cuatro (04) controles trimestrales. A partir de los dos hasta los cuatro años, se establecen dos (02) controles semestrales por cada año de edad, de acuerdo al siguiente detalle:

Grupo de Edad	N° controles	Edad	Frecuencia/Intervalo entre control
1 año	1° control	12 meses (360 a 389 días)	Trimestral Intervalo mínimo de 90 días
	2° control	15 meses (450 a 479 días)	
	3° control	18 meses (540 a 569 días)	
	4° control	21 meses (630 a 659 días)	
2 años	1° control	2 años (24 meses)	Semestral Intervalo mínimo de 180 días
	2° control	2 años 6 meses (30 meses)	
3 años	1° control	3 años (36 meses)	
	2° control	3 años 6 meses (42 meses)	
4 años	1° control	4 años (48 meses)	
	2° control	4 años 6 meses (54 meses)	

d. **Niños de 05 años hasta los 11 años, 11 meses y 29 días)**: Un (01) control anual.

Grupo de edad	N° control	Edad	Frecuencia/ Intervalo entre control
5 años	1° control	5 años (60 meses hasta los 71 meses y 29 días)	Anual Intervalo mínimo de 360 días
6 años	1° control	6 años (72 meses hasta los 83 meses y 29 días)	

7 años	1° control	7 años (84 meses hasta los 95 meses y 29 días)
8 años	1° control	8 años (96 meses hasta los 107 meses y 29 días)
9 años	1° control	9 años (108 meses hasta los 119 meses y 29 días)
10 años	1° control	10 años (120 meses hasta los 131 meses y 29 días)
11 años	1° control	11 años (132 meses hasta los 143 meses y 29 días)

6.5. El profesional de la salud que realiza el control de CRED explica de forma anticipada y continua cada acción al niño y a la madre, padre o cuidador principal, utilizando un lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión. Asimismo, cumple estrictamente las normas de bioseguridad, incluyendo el lavado de manos y la desinfección de equipos, entre otros.

6.6. VALORACIÓN

6.6.1. El profesional de la salud que realiza el control de CRED recopila, valida y analiza datos sobre el estado de salud y las condiciones del entorno del niño, a través de la observación directa al niño y su interacción con la madre, padre o cuidador principal, entrevista y revisión de documentos oficiales (Libreta de Cuidado Integral de Salud de la Niña y del Niño, documento de identificación, certificado de nacido vivo y carné de atención materna, entre otros).

La valoración comprende: La evaluación de los antecedentes personales, la realización de un examen físico completo, la valoración del estado nutricional a través de mediciones antropométricas, la vigilancia y tamizaje del desarrollo, detección de trastornos del espectro autista (TEA) y la detección de trastornos mentales y problemas psicosociales. Estas acciones se complementan con los resultados de laboratorio.

6.6.2. Evaluación de antecedentes

a. En el primer control de CRED, el profesional de la salud recaba y consigna en la Historia Clínica la información del niño, la madre, el padre o el cuidador principal. Esta evaluación incluye:

- Datos generales del niño y de la madre, padre o cuidador principal.
- Antecedentes personales: Perinatales, parto y nacimiento.
- Antecedentes patológicos.
- Antecedentes familiares.
- Identificación y valoración de factores de riesgo (individuales, familiares, psicosociales y medioambientales, entre otros) y factores de protección.
- Verificación y consigna en la historia clínica de la fecha de la vacuna, suplementación de micronutrientes, dosaje de hemoglobina, tamizaje neonatal y descarte de parasitosis, entre otros.

b. El profesional de la salud que realiza el control de CRED identifica, consigna y reevalúa en cada control de CRED los factores de riesgo (individuales, familiares y psicosociales), utilizando como referencia el Anexo N° 6. Ante la identificación o persistencia de un riesgo, el profesional de la salud implementa una atención diferenciada que incluye: Interconsulta o derivación correspondiente, un seguimiento

al cumplimiento de los controles de CRED, ajustar la programación de citas de manera flexible, dedicando tiempo específico para el control y dando seguimiento a los acuerdos y compromisos. Incluso se programan visitas domiciliarias cuando sea necesario.

c. En los siguientes controles el profesional de la salud indaga sobre el estado actual del niño. Esto incluye: La situación de salud desde el último control de CRED, verificación del cumplimiento del estado vacunal, el consumo y la adherencia al tratamiento o suplementación con hierro, consumo de vitamina A, resultados de los exámenes de laboratorio indicados para su edad, el dosaje de hemoglobina y el descarte de parasitosis, condición de la lactancia materna, alimentación complementaria, patrones de sueño, y actividad física, entre otros. Se da seguimiento a los acuerdos y compromisos del control anterior.

d. En caso de niños que viven en zonas con riesgo ambiental identificado (exposición a metales pesados, sustancias químicas, entre otros), el profesional de la salud que realiza el control de CRED evalúa la exposición individual y sus efectos en la salud, priorizando los signos y síntomas. Si sospecha o evidencia afectación, notifica el caso de inmediato al personal encargado de salud ambiental.

6.6.3. Examen físico

a. El profesional de la salud que realiza el control de CRED ejecuta el examen físico en cada control, adaptándolo a la edad del niño. Emplea técnicas como: Inspección, auscultación, palpación y percusión. Este procedimiento se realiza en la posición que asegura la comodidad del niño (camilla, colchoneta, superficie blanda, en brazos de la madre, padre o cuidador principal, o en la falda). El procedimiento detallado se encuentra en el Anexo N° 7.

b. El examen físico incluye:

- Examen físico general.
- Examen neurológico.
- Evaluación ocular y tamizaje visual.
- Evaluación de la función auditiva.
- Valoración de cadera y miembros inferiores.
- Búsqueda de signos de sospecha de cáncer.
- Búsqueda de signos de exposición a metales pesados.
- Identificación de signos y síntomas de maltrato físico.
- Exploración del desarrollo biológico.
- Inspección de la cavidad bucal.

c. El profesional de la salud que realiza el control de CRED, al identificar durante el examen físico alguna condición de riesgo, deriva, solicita interconsulta o refiere al niño al establecimiento de salud con la capacidad resolutiva correspondiente. Tanto el riesgo identificado como la acción realizada se registran en la Historia Clínica. Además, verifica el estado de salud y seguimiento del caso en el siguiente control de CRED.

6.6.4. Detección de trastornos mentales y problemas psicosociales

a. Durante el control de CRED, el profesional de la salud debe estar atento a los signos de alarma y factores de riesgo asociados a trastornos mentales y problemas psicosociales que puedan manifestar la madre, padre o cuidador principal. Para la detección de dichos problemas, se aplican los instrumentos descritos en la presente Norma Técnica de Salud, siguiendo el procedimiento detallado en el Anexo N° 8.

Instrumento	Condición a identificar	Momento de aplicación (según la edad del niño)
Escala de salud del paciente-9 (PHQ-9)	Depresión	Al primer mes, 12 meses, y posteriormente 01 vez al año desde los 2 hasta los 4 años, 11 meses y 29 días
Cuestionario de identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol (AUDIT-C)	Consumo de alcohol	

b. La detección de violencia a madres de niños menores de 5 años se realiza en las siguientes edades del niño (al primer mes, 12 meses, y posteriormente 01 vez al año desde los 2 años hasta los 4 años, 11 meses y 29 días).

- Para aplicar el instrumento, el profesional de la salud debe indagar activamente sobre signos de alarma y factores de riesgo, aplicando el listado de preguntas descritas en el Anexo N° 8.

- Cuando existen signos de alarma, factores de riesgo, y respuestas significativas que, a juicio del profesional de la salud, es una "sospecha de caso", se aplica el instrumento dispuesto en la Directiva Sanitaria N° 155-MINSA/DGIESP-2024, Directiva Sanitaria para el Cuidado Integral de la Salud Mental de Gestantes y Madres de Niñas y Niños Menores de 5 años, aprobada con Resolución Ministerial N° 120-2024/MINSA, o la que haga sus veces.

c. Independientemente de la periodicidad establecida, si durante cualquier control de CRED el profesional de la salud identifica, a través de la observación o el diálogo, signos de alarma que sugieran un riesgo, aplica de inmediato el instrumento correspondiente según su juicio clínico.

6.6.5. Detección de problemas emocionales, conductuales y atencionales en niños de 3 años hasta 11 años, 11 meses y 29 días

El profesional de la salud que realiza el control de CRED aplica instrumentos para la detección de problemas emocionales, conductuales y atencionales en niños de 3 años hasta 11 años, 11 meses y 29 días (ver Anexo N° 8), conforme al siguiente detalle:

Instrumento	Condición a identificar	Momento de aplicación (según edad del niño)
Lista de síntomas pediátricos para niños en edad preescolar (Preschool Pediatric Symptom Checklist - PPSC)	Problemas emocionales y conductuales	1 vez al año (desde los 3 años hasta los 5 años, 11 meses y 29 días)
Lista de verificación de síntomas pediátricos-17 (Pediatric Symptom Checklist – PSC17) A*daptación para padres y madres*		1 vez al año (desde los 6 años hasta los 11 años, 11 meses y 29 días)

6.6.6. Independientemente de la periodicidad establecida, si el profesional de la salud que realiza el control de CRED identifica en el niño retraso del desarrollo, crecimiento inadecuado o conductas regresivas, aplica inmediatamente el instrumento

correspondiente (PHQ-9, Test PSC17, AUDIT-C o detección de violencia a la madre de niños menores de 5 años) a la madre, padre o cuidador principal.

6.6.7. Valoración nutricional antropométrica

a. El profesional de la salud determina el estado nutricional del niño mediante la valoración nutricional antropométrica. Esta valoración permite la identificación de la tendencia del crecimiento y clasificación del estado nutricional.

b. En cada control de CRED, el profesional de la salud realiza las mediciones antropométricas, según la edad del niño, utilizando equipos estandarizados y calibrados. Estas mediciones **comprenden**:

- **De 0 a 28 días:** Peso, longitud y perímetro cefálico.
- **De 29 días a 4 años, 11 meses y 29 días:** Peso, longitud/estatura y perímetro cefálico.
- **De 5 años a 11 años, 11 meses y 29 días:** Peso, estatura y perímetro abdominal.

c. **El procedimiento para la medición antropométrica,** se realiza de acuerdo a lo establecido en la Guía Técnica para la Valoración Nutricional Antropométrica de la Niña y el Niño de 0 a 11 años, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 034-2024/MINSA, o la que haga sus veces. También se deben tener en cuenta las recomendaciones detalladas en el Anexo N° 9.

d. Finalizada la medición, el profesional de la salud registra de forma inmediata y precisa los valores obtenidos (peso, longitud/estatura y perímetros) en la Historia Clínica y en la Libreta de Cuidado Integral de Salud de la Niña y del Niño. Asimismo, gráfica y valora los indicadores nutricionales (peso/edad, talla/edad, peso/talla, IMC/edad y perímetro cefálico/edad), utilizando los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

6.6.8. Vigilancia y tamizaje del desarrollo infantil

a. La vigilancia del desarrollo se realiza utilizando como instrumento el "test de vigilancia del neurodesarrollo (Huanca Test)",[1] en niños hasta los 36 meses, y para niños de 4 años hasta los 11 años, 11 meses y 29 días, se realiza a través de la "Lista de Habilidades y Conductas Esperadas por Edad". Los instrumentos y el procedimiento se detallan en el Anexo N° 10.

b. **El** tamizaje del desarrollo se realiza utilizando como instrumento la "prueba de evaluación del desarrollo infantil (EDI)" a todos los niños desde un mes hasta 60 meses. El procedimiento y ficha de aplicación se describe en el Anexo N° 10.

c. La vigilancia y el tamizaje del desarrollo infantil, se realizan según el siguiente detalle:

Edad	Procedimiento
1 mes (29 a 59 días)	**Tamizaje**
2 meses (60 a 89 días)	Vigilancia
3 meses (90 a 119 días)	Vigilancia
4 meses (120 a 149 días)	Vigilancia
6 meses (180 a 209 días)	**Tamizaje**
7 meses (210 a 269 días)	Vigilancia

[1] Adaptado de: Huanca D. Guía de Vigilancia del Neurodesarrollo. Manual de Aplicación. 1ª Ed. Lima: Fondo Editorial IIDENUT SA; 2023

9 meses (270 a 299)	**Tamizaje**
12 meses	Vigilancia
15 meses	Vigilancia
18 meses	**Tamizaje**
21 meses	Vigilancia
2 años (24 meses)	Vigilancia
2 años 6 meses (30 meses)	**Tamizaje**
3 años (36 meses)	Vigilancia
3 años 6 meses (42 meses)	**Tamizaje**
4 años (48 meses)	Vigilancia
5 años (60 meses)	**Tamizaje**
De 6 hasta 11 años, 11 meses y 29 días	Vigilancia anual

d. Finalizada la vigilancia o tamizaje de desarrollo, el profesional de la salud registra de forma inmediata los hallazgos y resultados obtenidos de los instrumentos aplicados, en la Historia Clínica, en la Libreta de Cuidado Integral de Salud de la Niña y del Niño y en otros formatos, según corresponda.

e. El profesional de la salud inicia excepcionalmente el tamizaje con la prueba de EDI, independientemente que la edad del niño coincida con la periodicidad, en las siguientes situaciones:

- Cuando un niño acude a su primer control de CRED en una edad mayor a los controles iniciales (captación tardía).
- Cuando los controles de CRED no han sido oportunos, perdiéndose la secuencia de vigilancia.
- Cuando existen antecedentes perinatales o factores de riesgo significativos (ver Anexo N° 6) que, a juicio del profesional, justifiquen una evaluación más profunda.

6.6.9. Detección del Trastorno de Espectro Autista (TEA) en niños

El profesional de la salud debe aplicar la *Lista de verificación modificada para el autismo en niños pequeños* (Modified Checklist for Autism in Toddlers -M-CHAT-R/F) para la detección del Trastorno de Espectro Autista (TEA). Este instrumento es de aplicación universal a todos los niños a los 24 meses de edad, y su procedimiento se detalla en el Anexo N° 11.

6.7. DIAGNÓSTICO

El profesional de la salud determina el estado de salud, nutrición, crecimiento y desarrollo del niño, a partir del análisis y la interpretación de los hallazgos consignados en la valoración.

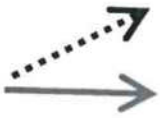
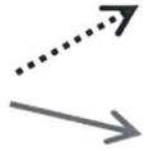
6.7.1. Evaluación del crecimiento

a. La evaluación del crecimiento se determina tomando en consideración la tendencia de la curva de crecimiento.

- El crecimiento se considera adecuado cuando la tendencia es paralela a la mediana en su canal de crecimiento.
- El crecimiento se considera inadecuado (señal de alerta) cuando la tendencia muestra un cambio de carril, un descenso o un incremento en exceso, o cuando la línea de crecimiento del niño se mantiene estancada.

- **Por déficit:** Poco o nulo incremento de peso y longitud o talla, incluyendo la pérdida de peso.
- **Por exceso:** Incremento excesivo de peso, longitud o talla.

Tabla N° 1 Crecimiento de la niña o niño considerando la tendencia

Condición del Crecimiento	Anotación	Significado
CRECIMIENTO ADECUADO		La señal indica buen crecimiento, traducido en un incremento favorable de peso, longitud o estatura de la niña o niño, visualizado de un control a otro. La tendencia es paralela a un patrón de referencia. Los valores de las medidas antropométricas se encuentran dentro del rango de normalidad **(+2/-2DS).**
CRECIMIENTO INADECUADO (señal de alerta)		La señal indica poco incremento de peso, longitud o estatura de la niña o niño, visualizado de un control a otro. La tendencia no es paralela a un patrón de referencia. Los valores de las medidas antropométricas se encuentran dentro del rango de normalidad **(+2/-2DS).**
		La señal indica crecimiento inadecuado, traducido en incremento nulo de peso, longitud o estatura de la niña o niño, visualizado de un control a otro. La tendencia no es paralela a un patrón de referencia. Los valores de las medidas antropométricas se encuentran dentro del rango de normalidad **(+2/-2DS).**
		La señal indica crecimiento inadecuado, traducido en pérdida de peso, longitud o estatura de la niña o niño, visualizado de un control a otro. La tendencia no es paralela a un patrón de referencia. Los valores de la medida antropométrica se encuentran dentro del rango de normalidad **(+2/-2DS).**
		La señal indica crecimiento inadecuado, traducido en ganancia de peso excesiva para su edad de un control a otro. La tendencia se eleva muy por encima de la curva de referencia.

b. Para la evaluación del estado nutricional, el profesional de la salud utiliza los siguientes indicadores:

Tabla Nº 2 Indicadores nutricionales

Indicador	Definición	Grupo de edad a utilizar
Peso para la edad (P/E)	Refleja la masa corporal (peso) alcanzada para la edad cronológica. Es un indicador muy útil para monitorear el crecimiento de un niño, ***sobre todo en el primer año de edad.***	≥ a 29 días a < 5 años
Peso para la talla (P/T)	Refleja el peso relativo para la longitud o talla del niño. Indica el **estado nutricional actual del niño.**	≥ a 29 días a < 5 años
Talla para la edad (T/E)	Refleja el crecimiento longitudinal alcanzado en relación a la edad cronológica. Indica si hubo problemas relacionados al **estado nutricional del niño en el pasado.**	≥ a 29 días a < 11 años
Perímetro cefálico para edad (PC/E)	Macrocefalia o microcefalia.	≥ a 29 días a < 3 años
IMC = Peso/ talla²	IMC es un indicador que relaciona el peso de la persona con su talla; permite evaluar los niveles de delgadez, normal, sobrepeso y obesidad.	≥ a 5 años

c. El profesional de la salud clasifica el estado nutricional del niño y establece el diagnóstico, de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla N° 3 Clasificación del estado nutricional de los niños, según indicadores nutricionales

Grupo Etario	Indicador	Clasificación	Puntos de Corte (Desviación Estándar - DE)
Menores de 5 años	Peso para edad	Sobrepeso	>+ 2 DE
		Normal	+ 2 a – 2 DE
		Bajo peso	< - 2 a – 3 DE
		Bajo peso severo	< - 3
	Peso para talla	Obesidad	>+ 3
		Sobrepeso	>+ 2 DE
		Normal	+ 2 a – 2 DE
		Bajo peso /Emaciado	< - 2 a – 3 DE
		Bajo peso severo	< - 3
	Talla para edad	Alto	>+ 2 DE
		Normal	+ 2 a – 2 DE
		Talla baja	< - 2 a – 3 DE
		Talla baja severa	< - 3
	Perímetro cefálico para edad (PC/E)	Riesgo microcefalia	< -2 DE
		Normal	≥ -2 A ≤ -2
		Riesgo macrocefalia	> +2 DE

5 a 11 años, 11 meses y 29 días	Índice de Masa Corporal para la edad (IMC/edad)	Obesidad	> + 2 DE *Para niños con IMC ≥ 3 DE son considerados como "obesidad severa".
		Sobrepeso	> +1 DE a +2 DE
		Normal	+ 1 DE a -2 DE
		Delgadez	< - 2 DE a -3 DE
		Delgadez severa	< - 3 DE
	Talla para la edad (T/E)	Talla alta	> + 2 DE
		Normal	+ 2 DE a – 2 DE
		Talla baja	< - 2 DE a – 3 DE
		Talla baja severa	< - 3 DE

Fuente: Guía Técnica para la Valoración Nutricional Antropométrica de la Niña y el Niño de 0 a 11 Año aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 034-2024/MINSA

d. El profesional de la salud que realiza el control de CRED complementa la interpretación de los indicadores nutricionales con los antecedentes, el examen físico, el descarte de enfermedades prevalentes, la vigilancia y tamizaje de desarrollo, así como el ritmo de crecimiento individual del niño.

e. El profesional de la salud que realiza el control de CRED, informa los resultados de la evaluación a la madre, padre o cuidador principal de manera clara y sencilla, ayuda a comprender a la madre la condición actual del crecimiento y estado nutricional del niño, y promueve la adopción de acciones oportunas para un crecimiento saludable.

6.7.2. Interpretación de los resultados de la vigilancia en niños de 0 a 36 meses

En cada control de CRED, se determina la condición del desarrollo con base en el resultado de la aplicación del "test de vigilancia", de acuerdo al siguiente detalle:

- **Normal:** Cuando el niño logra todos los hitos de desarrollo esperados para su edad.
- **Hallazgo positivo:**
  - Cuando el niño o niña no logra un (01) hito para su edad.
  - Cuando el niño o niña no logra dos (02) o más hitos para su edad (ver Anexo N° 10).

6.7.3. Interpretación de la vigilancia del desarrollo en niños de 4 a 11 años, 11 meses y 29 días

El profesional de la salud que realiza el control de CRED interpreta que existe ausencia de habilidades o conductas esperadas cuando un niño no logra demostrar una o más de las habilidades o conductas esperadas para su edad, y existe algún factor de riesgo descrito en el Anexo N° 6.

6.7.4. Interpretación de los resultados del tamizaje del desarrollo

El profesional de la salud interpreta los resultados de la prueba de EDI con base en sus 5 ejes (factores de riesgo biológico, señales de alerta, áreas del desarrollo, exploración neurológica y señales de alarma), de la siguiente manera:

- **Resultado VERDE (desarrollo normal):** Indica que el niño ha alcanzado los hitos y habilidades de desarrollo esperados para su grupo de edad, sin señales de alarma ni alteraciones neurológicas.

- **Resultado AMARILLO (rezago en el desarrollo):** Significa que el niño no ha alcanzado los hitos y habilidades esperadas para su grupo de edad, pero sí cumple los de la edad anterior, indicando potencial de recuperación. Si el resultado es amarillo en dos ocasiones consecutivas, el caso se clasifica como rojo.

- **Resultado ROJO (riesgo de retraso):** Significa que el niño no ha logrado alcanzar los hitos y habilidades esperadas para su grupo de edad ni las del grupo de edad anterior, o presenta alteraciones neurológicas o señales de alarma asociadas a trastornos del desarrollo

6.7.5. Interpretación de los resultados de la detección del Trastorno de Espectro Autista (TEA) en niños

El profesional de la salud determina y clasifica el riesgo de Trastorno de Espectro Autista (TEA), de la siguiente manera:

- **De 0 a 2 puntos (bajo riesgo o tamizaje negativo):** Indica un bajo riesgo de TEA. Un tamizaje negativo no descarta un desarrollo posterior de TEA ni otros problemas del desarrollo.

- **De 3 a 7 puntos (riesgo moderado):** Indica un riesgo moderado de TEA.

- **De 8 a más puntos (riesgo alto):** Indica un riesgo alto de TEA.

6.7.6. Interpretación de los hallazgos y/o resultados de:

a. **Antecedentes personales:** Se establece por la identificación de factores de riesgo o de protección consignados durante la valoración, conforme al Anexo N° 6.

b. **Examen físico:** Se establece al identificar un signo de alarma durante la ejecución de los procedimientos descritos en el Anexo N° 7.

c. **Detección de trastornos mentales y problemas psicosociales:** La condición de riesgo se determina al obtener un resultado de "Tamizaje Positivo", según los puntos de corte especificados para cada instrumento (PHQ-9, AUDIT-C, PSC17, PSC o detección de violencia a madres de niños menores de 5 años), tal como se describe en el Anexo N° 8.

6.7.7. En todos los casos, el profesional de la salud registra los hallazgos, la interpretación y las acciones tomadas en la Historia Clínica, y brinda información sobre el resultado a la madre, padre o cuidador principal, de forma sencilla y clara.

6.8. INTERVENCIÓN

6.8.1. La intervención comprende las acciones que el profesional de la salud realiza una vez culminado el proceso de valoración y diagnóstico en el control de CRED, de acuerdo a los hallazgos y resultados.

6.8.2. El profesional de la salud que realiza el control de CRED brinda consejería en cada control, abordando los temas prioritarios según edad y hallazgos.

a. El profesional de la salud aplica los cinco momentos de la consejería detallados en el Anexo N° 12, con el fin de establecer acuerdos y compromisos con la madre, padre y cuidador principal.

- **MOMENTO 1: Explicación de la situación encontrada**

El profesional de la salud explica los hallazgos relevantes, utiliza lenguaje claro y recursos educativos, y consigna dichos hallazgos en la Historia Clínica y la Libreta de Cuidado Integral de Salud de la Niña y del Niño.

- **MOMENTO 2: Análisis conjunto y priorización**

  El profesional de la salud indaga y analiza con la familia las posibles causas de los hallazgos. Prioriza y define un máximo de dos (02) prácticas a mejorar, las cuales sirven de base para los acuerdos.

- **MOMENTO 3: Negociación de alternativas y acuerdos**

  El profesional de la salud felicita las prácticas adecuadas y negocia las mejoras, presentando alternativas factibles. Obtiene el compromiso verbal explícito sobre las prácticas a implementar.

- **MOMENTO 4: Registro de acuerdos**

  El profesional de la salud consigna los acuerdos y compromisos asumidos en la Historia Clínica, en la Libreta de Cuidado Integral de Salud de la Niña y del Niño y en el formato de registro correspondiente.

- **MOMENTO 5: Seguimiento de acuerdos**

  El profesional de la salud establece la fecha del próximo control, verifica el cumplimiento de los acuerdos y refuerza su importancia.

b. Para la consejería, el profesional de la salud considera los siguientes temas, priorizando la edad, los hallazgos, y basándose en normatividad vigente:

- **Alimentación en lactantes de cero a seis meses (lactancia materna exclusiva)**
  - El profesional de la salud resuelve dudas o consultas de la madre, padre o cuidador principal para asegurar la sostenibilidad de la lactancia materna exclusiva (LME) hasta los 6 meses.
  - La consejería en lactancia materna se rige por la Guía Técnica para la Consejería en Lactancia Materna, aprobada por Resolución Ministerial N° 462-2015/MINSA, o la que haga sus veces.

- **Alimentación complementaria de 6 a 23 meses**
  - Al brindar consejería en alimentación complementaria, el profesional de la salud considera la integralidad, el desarrollo progresivo, la alimentación responsiva y el uso de alimentos naturales o mínimamente procesados.
  - La consejería en alimentación complementaria se efectúa conforme al documento normativo vigente sobre la materia. Para niños de 6 a 24 meses, se aplican los mensajes del Documento Técnico: Guías Alimentarias para niñas y niños menores de 2 años de edad, aprobado con Resolución Ministerial N° 967-2020/MINSA, o la que haga sus veces.
  - Para la consejería nutricional en menores de 12 meses, se utiliza el Kit del Buen Crecimiento Infantil, siguiendo los procedimientos que se describen en el Anexo N° 13.

- **Alimentación saludable para niños mayores de 24 meses**
  - Para la consejería en niñas y niños mayores de dos años, se deben priorizar temas como la promoción de una alimentación saludable y la preparación de la lonchera escolar,
  - Para niños mayores de 2 años hasta 11 años, 11 meses y 29 días, se aplica el Documento Técnico: Guías Alimentarias para la Población Peruana, aprobado por Resolución Ministerial N° 1353-2018/MINSA, o el que haga sus veces.

- **Suplementación con hierro o micronutrientes**
  - Esta abarca la importancia de su consumo, posibles efectos colaterales y conservación, conforme a la NTS N° 213-MINSA/DGIESP-2024, Norma Técnica de Salud: Prevención y control de la anemia por deficiencia de hierro en el niño y la niña, adolescentes, mujeres en edad fértil, gestantes y puérperas, aprobada por Resolución Ministerial N° 251-2024/MINSA, o la que haga sus veces.

- **Salud bucal**
  - En establecimientos que cuenten con cirujano dentista, el profesional de la salud deriva a la madre, padre o cuidador principal para que reciba orientación sobre medidas educativas y evaluación, de corresponder.
  - Si el establecimiento no cuenta con cirujano dentista, el profesional de la salud brinda orientación sobre medidas educativas en salud bucal, según Anexo N° 7.

- **Desarrollo infantil**
  - En cada control de CRED el profesional de la salud brinda pautas sobre la necesidad de un espacio de juego en el hogar, la elaboración de juguetes y orientaciones de crianza. Asimismo, orienta a la madre, padre o cuidador principal sobre signos y señales de alerta en el desarrollo (ver Anexo N° 14).

c. Otros temas de consejería relevantes, según los hallazgos en el control y la edad del recién nacido y del niño. Estos incluyen consejería sobre actividad física, atención temprana del desarrollo, corte y cuidado del cordón umbilical, apego y comunicación, y estilos de vida saludable. También se brinda orientación sobre higiene menstrual y lonchera saludable, habilidades sociales, higiene de manos, higiene del recién nacido o niño y cuidado en el hogar, esquema de vacunación, prácticas saludables para la salud respiratoria, prevención de accidentes y enfermedades prevalentes (como enfermedad diarreica aguda (EDA) e infección respiratoria aguda (IRA)).

6.8.3. Intervenciones específicas

a. Intervención según la vigilancia del desarrollo en niños hasta 36 meses:

- **Normal:** El profesional de la salud brinda consejería para el fomento del desarrollo y continúa con los controles de CRED, según corresponda por edad.
- **Cuando el niño o niña no logran un (01) hito para su edad:** El profesional de la salud debe ejecutar de forma inmediata las siguientes acciones:

  - Brindar consejería en desarrollo infantil, enfocada en el área en riesgo.
  - Programar sesiones semanales de Atención Temprana del Desarrollo (ATD).
  - Citar para un control de seguimiento al mes para reevaluar el hito. Si persiste el resultado, se mantienen las sesiones de ATD y se aplica la prueba de tamizaje EDI.

- **Cuando el niño o niña no logran dos (02) o más hitos para su edad:** El profesional de la salud debe ejecutar de forma inmediata las siguientes acciones:

  - Programar sesiones semanales de Atención Temprana del Desarrollo (ATD).
  - Aplicar la prueba de tamizaje del desarrollo (EDI), según lo establecido en el presente documento normativo.

b. Intervención según resultado de la vigilancia del desarrollo en niños de 4 hasta 11 años, 11 meses y 29 días:

- **Cuando hay ausencia de habilidades o conductas esperadas, además de un factor de riesgo**.

- Para niños de 4 a 5 años (hasta 60 meses): Aplica la prueba de EDI inmediatamente, o en un plazo no mayor a tres (3) días.
- Para niños mayores de 5 años (más de 60 meses): Realiza la interconsulta, derivación o referencia inmediata al médico cirujano o psicólogo para una evaluación especializada.

c. Intervención según resultados del tamizaje del desarrollo:

- **Resultado verde (desarrollo normal):** Brinda información sobre señales de alarma y alerta, y sobre promoción del desarrollo infantil.

- **Resultado amarillo (rezago en el desarrollo):** Programa sesiones de atención temprana del desarrollo semanalmente. Repite la prueba de EDI en el siguiente control. Si el resultado es amarillo en dos ocasiones consecutivas, el caso se clasifica como rojo, y se aplica la intervención establecida para dicho resultado.

- **Resultado rojo (riesgo de retraso en el desarrollo):** Realiza la interconsulta y derivación inmediata al profesional de la salud médico cirujano o psicólogo, para evaluación, que incluye uso de instrumentos como Batelle o Bailey. Programa una cita de seguimiento y sesiones de atención temprana del desarrollo semanalmente.

d. Intervención según resultados de la detección del TEA

- **Para 0 a 2 puntos (bajo riesgo o tamizaje negativo):** Se continúa con la vigilancia o tamizaje del desarrollo.

- **Para 3 a 7 puntos (riesgo moderado):** Se programa un control de seguimiento en un (01) mes. Si persiste el resultado positivo, se realiza la interconsulta, derivación o referencia al profesional de la salud (médico cirujano o psicólogo) y se programan sesiones de atención temprana del desarrollo.

- **Para 8 o más puntos (riesgo alto):** Se realiza la interconsulta, derivación o referencia al profesional de la salud (médico cirujano o psicólogo) y se programan sesiones de atención temprana del desarrollo.

e. Intervenciones ante hallazgos y resultados en: Antecedente, examen físico, detección de trastornos mentales y problemas psicosociales (madre, padre o cuidador principal), detección de problemas emocionales, conductuales y atencionales (niño).

- El profesional de la salud que realiza el control de CRED debe ejecutar de forma inmediata la interconsulta o derivación del niño al profesional correspondiente ante hallazgos relevantes.
- En caso de no contar con el profesional requerido en el establecimiento, se gestiona la referencia del niño a un establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva o a un centro de salud mental comunitario, según corresponda.

6.8.4. Intervenciones complementarias

a. Suplemento con Vitamina A para niños: El profesional de la salud que realiza el control de CRED entrega la Vitamina A de acuerdo a la normatividad vigente (ver Anexo N° 15).

Tabla N° 4: Esquema de administración preventiva de Vitamina A en niños de 6 a 59 meses de edad

EDAD	DOSIS	FRECUENCIA
Niños: 6 - 11 meses	100,000 UI (30mg en equivalentes de retinol)	Entrega única
Niños: 12 - 59 meses	200,000 UI (60mg en equivalentes de retinol)	Una dosis cada seis meses 12, 18, 24,30,36,42,48,54 meses

Fuente: Organización Mundial de la Salud,2011

b. **Suplementación de hierro y vacunación:** El profesional de la salud que realiza el control de CRED verifica el cumplimiento del esquema de vacunación y la suplementación de hierro para la prevención o tratamiento de la anemia. La entrega del suplemento y la vacunación se realizan de acuerdo a la organización del establecimiento de salud, mediante la derivación a otro servicio o en el control de CRED, de conformidad a la normatividad vigente o la que haga sus veces.

c. **Solicitud de exámenes de laboratorio:** El profesional de la salud, al identificar durante la valoración la falta de resultados del dosaje de hemoglobina o del tamizaje neonatal en el niño, según corresponda a la edad, gestiona la toma de los exámenes de acuerdo con la organización del establecimiento de salud, pudiendo ser derivado a otro servicio o gestionar la referencia a otro establecimiento.
De igual manera, debe solicitar anualmente el descarte de parasitosis (Test de Graham y examen seriado) a partir del primer año de edad. El profesional de la salud realiza el seguimiento de los resultados de estos exámenes en el siguiente control.

6.8.5. Ante cualquier hallazgo positivo o la identificación de un problema, el profesional de la salud realiza la interconsulta, derivación o referencia correspondiente para su manejo y tratamiento. Garantiza la continuidad de los controles de CRED coordinando con la madre, padre o cuidador principal la programación de las citas. Asimismo, registra obligatoriamente las intervenciones realizadas, en la Historia Clínica y en otros formatos, de corresponder.

6.8.6. Programación de sesiones de Atención Temprana del Desarrollo (ATD)

a. Todo establecimiento de salud que, dentro de su cartera de servicio, tiene el control de CRED, realiza las sesiones de ATD. La sesión está a cargo del profesional de la salud de enfermería, y se desarrolla según se detalla en el Anexo N° 16.

b. El profesional de la salud que realiza el control de CRED programa con prioridad la participación en las sesiones de ATD a los niños que presenten al menos uno de los siguientes criterios:

- Madre o padre adolescente.
- Nacimiento prematuro o bajo peso al nacer.
- Rezago o riesgo en el desarrollo identificado.
- Pertenencia a programas sociales o situación de pobreza.
- Riesgo de violencia o vulnerabilidad social.
- Pertenencia a población indígena, afroperuana o migrante.
- Crecimiento inadecuado o problemas de malnutrición.

6.9. SEGUIMIENTO

6.9.1. El profesional de la salud que realiza el control de CRED, ejecuta el seguimiento al niño bajo dos (02) modalidades: Fija y móvil, con el objetivo de asegurar la recuperación de la salud del niño y fortalecer las prácticas de cuidado de la madre, padre o cuidador

principal. El seguimiento se realiza de forma complementaria al diagnóstico y manejo especializado.

a. Modalidad Fija: A través de citas en el establecimiento de salud.

- El profesional de la salud que realiza el control de CRED programa las citas de seguimiento al finalizar cada atención, en coordinación con la madre, padre o cuidador principal, según hallazgo:

  - Para niños con crecimiento inadecuado o malnutrición, el profesional de la salud programa citas de seguimiento con una frecuencia de 7 a 15 días. En cada cita realiza las mediciones antropométricas, analiza la tendencia de las curvas, brinda consejería y realiza la interconsulta o derivación al profesional de la salud (médico cirujano o nutricionista), si no observa una recuperación.

  - Para niños con rezago o riesgo de retraso en el desarrollo, el profesional de la salud programa citas mensuales adicionales. En cada cita, el profesional de la salud evalúa la evolución a través de la aplicación de la prueba de EDI, brinda consejería sobre juego y vínculo, e interviene según el resultado de la prueba de EDI. Además, garantiza la participación del niño en sesiones de ATD.

b. Modalidad móvil: A través de visita domiciliaria

- El profesional de la salud realiza visitas domiciliarias para consolidar las prácticas de cuidado y verificar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos. Prioriza la programación de estas visitas para niños que presentan al menos uno de los siguientes criterios:

  - Niños nacidos en domicilio.
  - Niños prematuros y/o con bajo peso al nacer.
  - Niños que no acuden a citas programadas.
  - Niños que presentan crecimiento inadecuado.
  - Niños con rezago o riesgo de retraso en el desarrollo.
  - Niños en riesgo y víctimas de violencia o maltrato infantil.
  - Niños con padres adolescentes.
  - Niños de población indígena, afroperuana, bilingüe y migrante.

6.9.2. La frecuencia de las citas de seguimiento se incrementa según el criterio del profesional de la salud, considerando los factores de riesgo o problemas de salud del niño. En las guardias comunitarias se incluye el seguimiento de los niños priorizados, además de la captación de nuevos niños.

6.9.3. El profesional de la salud programa las fechas para el seguimiento, asegurando un monitoreo continuo y adaptado a las necesidades individuales. Todas las actividades de seguimiento, en ambas modalidades, se registran de forma precisa en la Historia Clínica.

VII. COMPONENTE DE GESTIÓN

7.1. Planificación

7.1.1. La DIRESA/GERESA/DIRIS, y UE con establecimientos de salud que, en su cartera de servicios, incluyan el control de CRED, así como el Seguro Social de Salud (EsSalud), las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, e IPRESS privadas y mixtas, aseguran que el control de crecimiento y desarrollo (CRED) esté incluido en el Plan Operativo Institucional (POI) o documento de gestión equivalente.

7.1.2. Según la necesidad, la DIRESA/GERESA/DIRIS, y UE con establecimientos de salud que, en su cartera de servicios, incluyan el control de CRED, así como el Seguro Social de Salud (EsSalud), las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, e IPRESS privadas y mixtas, formulan planes específicos que permitan mejora de acceso, cobertura, oportunidad y calidad del control de CRED, mediante la gestión eficiente de los recursos necesarios.

Cada establecimiento de salud que oferte el control de CRED en su cartera de servicios, es responsable de programar a todos los niños de 0 a 11 años, 11 meses y 29 días, adscritos a su jurisdicción. Dicha programación debe realizarse según los criterios descritos en el Anexo N° 17.

7.1.3. La asignación de recursos humanos para el control de CRED se determina por la meta física, el tiempo promedio utilizado por control (un promedio de 30 minutos), las características de la demanda, la dispersión de la población, la capacidad instalada (número de consultorios), la categoría y la capacidad resolutiva del establecimiento de salud. Se resumen las actividades del control de CRED por edad en la tabla del Anexo N° 18.

7.2. Organización

7.2.1. La jefatura de los establecimientos de salud públicos, mixtos o privados que, en su cartera de servicios, incluyan el control de CRED, asegura la asignación formal de recurso humano para el desarrollo del control de CRED, y gestiona las acciones administrativas necesarias (habilitar la rotación o desplazamiento temporal, ajuste de días y horarios de atención).

7.2.2. La jefatura de los establecimientos de salud públicos, mixtos o privados que, en su cartera de servicios, incluyan el control de CRED, organiza la referencia y contrarreferencia para garantizar la continuidad de la atención.

7.2.3. Los establecimientos de salud públicos, mixtos o privados que, en su cartera de servicios, incluyan el control de CRED, implementan un flujograma flexible y adaptable a la realidad local. Para atender los problemas identificados, el profesional de la salud realiza una interconsulta, derivación o referencia del niño a otro establecimiento de mayor complejidad.

7.2.4. La jefatura de los establecimientos de salud públicos, mixtos o privados que, en su cartera de servicios, incluyan el control de CRED, identifica las necesidades de infraestructura, equipamiento y mobiliario, y gestiona las acciones administrativas para asegurar que se cumpla con las condiciones de espacio, privacidad, seguridad, comodidad, pertinencia cultural, así como las condiciones técnicas de acuerdo al Anexo N° 3.

7.2.5. En situaciones de emergencia sanitaria o zonas de difícil acceso, los establecimientos de salud públicos, mixtos o privados que, en su cartera de servicios, incluyan el control de CRED, realizan las gestiones para la prestación ininterrumpida de los controles de CRED en la población. El profesional de la salud coordina las acciones para la obtención de un ambiente adecuado y la realización del control, según lo establecido en la presente Norma Técnica de Salud, y asegura el correcto registro de la información.

7.3. Control

7.3.1. La DIRESA/GERESA/DIRIS, y UE con establecimientos de salud que, en su cartera de servicios, incluyan el control de CRED, así como el Seguro Social de Salud (EsSalud), las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, e IPRESS privadas y mixtas; son las encargadas de realizar el monitoreo, supervisión y evaluación

de avance de metas, desempeño de los profesionales y logro de resultados, de forma sistemática bajo las modalidades virtual y presencial.

7.3.2. El nivel nacional realiza la supervisión presencial al nivel regional como mínimo una vez al año, y adicionalmente cuando sea requerido por la DIRESA/GERESA/DIRIS y demás IPRESS de salud. Por su parte, el nivel regional supervisará a sus niveles operativos en función de sus recursos y necesidades, con una frecuencia mínima de cuatro veces al año.

7.3.3. El monitoreo y evaluación se realiza a nivel nacional, regional y local, a través de indicadores de estructura, proceso y resultado, los mismos que corresponden al control de CRED de los niños y niñas de 0 a 11 años, 11 meses y 29 días de edad. Los indicadores de proceso son evaluados de manera trimestral o semestral según la Tabla N° 5, y los indicadores de resultado son de evaluación semestral o anual.

Tabla N° 5: Lista de indicadores

N°	INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	PERIODO
A. PROCESO				
A.1. INDICADOR DE ACCESO				
1	Porcentaje de recién nacidos con primer control CRED	N° de Recién Nacidos con primer control CRED antes de los 7 días de vida	Total de recién nacidos según padrón nominal	Trimestral y Semestral
2	Porcentaje de < 1 año con primer control CRED	N° de niños y niñas de 1 mes de edad con primer control CRED	Total de niños y niñas < 1 año según padrón nominal	
3	Porcentaje de niños y niñas de 1 año con primer control CRED	N° de niños y niñas de 1 año de edad con primer control CRED	Total de niños y niñas de 1 año según padrón nominal	
4	Porcentaje de niños y niñas de 2 a 4 años con primer control CRED	N° de niños y niñas de 2 a 4 años de edad con primer control CRED	Total de niños y niñas de 2 a 4 año según padrón nominal	
5	Porcentaje de niños y niñas de 5 a 11 años con primer control CRED	N° de niños y niñas de 5 a 11 años de edad con primer control CRED	Total de niños y niñas de 5 a 11 años programados	
A.2. INDICADOR DE COBERTURA				
7	Porcentaje de recién nacidos con CRED completo	N° de recién nacidos con tercer control CRED	Total de recién nacidos según padrón nominal	Trimestral y Semestral
8	Porcentaje de niños y niñas < 1 año con CRED completo	N° de niños y niñas < 1 año de edad con sétimo control CRED	Total de niños y niñas < 1 año según padrón nominal	
9	Porcentaje de niños y niñas de 1 año con CRED completo	N° de niños y niñas de 1 año de edad con cuarto control CRED	Total de niños y niñas de 1 año según padrón nominal	
10	Porcentaje de niños y niñas de 2 a 4 años con CRED completo	N° de niños y niñas de 2 a 4 años de edad con segundo control CRED (por año)	Total de niños y niñas de 2 a 4 años según padrón nominal	
11	Porcentaje de niños y niñas de 5 a 11 años con CRED completo	N° de niños y niñas de 5 a 11 años de edad con primer control CRED (por año)	Total de niños y niñas de 5 a 11 años programados	
A.3. INDICADOR DE DESERCIÓN				
12	Deserción de recién nacidos en CRED completo	N° de recién nacidos con tercer control CRED	N° de recién nacidos con primer control CRED	Trimestral y Semestral

13	Deserción de niños y niñas < 1 año en CRED completo	N° de niños y niñas de < 1 año de edad con sétimo control CRED	N° de niños y niñas de > 1 año de edad con primer control CRED	
14	Deserción de niños y niñas de 1 año en CRED completo	N° de niños y niñas de 1 año de edad con cuarto control CRED	N° de niños y niñas de 1 año de edad con primer control CRED	
15	Deserción de niños y niñas de 2 a 4 años en CRED completo	N° de niños y niñas de 2 a 4 años de edad con segundo control CRED (por año)	N° de niños y niñas de 2 a 4 años de edad con primer control CRED	
B.4. NDICADORES DE CALIDAD DE ATENCIÓN				
16	Porcentaje de niños menores de 36 meses con rezago/riesgo de retraso en el desarrollo	Nº de niños y niñas menores de 36 meses con rezago/riesgo de retraso en el desarrollo	Total de niños y niñas menores de 36 meses atendidos en el control de CRED	Trimestral y Semestral
17	Porcentaje de niños menores de 24 meses con crecimiento inadecuado.	Nº de niños y niñas menores de 24 meses con crecimiento inadecuado.	Total de niños y niñas menores de 24 meses atendidos en el control de CRED.	
18	Porcentaje de niños menores de 36 meses con trastorno del desarrollo (retraso)	Nº de niños y niñas menores de 36 meses con trastorno del desarrollo (retraso)	Total de niños y niñas menores de 36 meses atendidos en el control de CRED	
B. RESULTADO				
19	Porcentaje de niños menores de 6 meses con control de CRED con lactancia materna exclusiva.	Niños y niñas de 6 meses con lactancia materna exclusiva atendidos en el control CRED	Niños y niñas de 6 meses atendidos en el control CRED	Semestral Anual
20	Porcentaje de niños menores de 24 meses con crecimiento inadecuado recuperados.	Nº de niños y niñas menores de 24 meses con crecimiento inadecuado recuperados.	Total de niños y niñas menores de 24 meses atendidos en el control de CRED con crecimiento inadecuado en el crecimiento.	
21	Porcentaje de niños menores de 24 meses con rezago/riesgo de retraso en el desarrollo recuperados.	Nº de niños y niñas menores de 24 meses con rezago/riesgo de retraso en el desarrollo recuperados.	Total de niños y niñas menores de 24 meses atendidos en el control de CRED con rezago/riesgo de retraso en el desarrollo.	
22	Porcentaje de niños menores de 36 meses con controles CRED completos según su edad.	Nº de niños y niñas menores de 36 meses con controles de CRED completos según su edad.	Total de niños y niñas menores de 36 meses.	

7.4. Gestión del conocimiento

7.4.1. La DIRESA/GERESA/DIRIS, y UE con establecimientos de salud que, en su cartera de servicios, incluyan el control de CRED, así como el Seguro Social de Salud (EsSalud), las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, e IPRESS privadas y mixtas; promueven y facilitan la realización de investigación operativa. Dicha investigación se orienta a generar evidencia para la mejora continua de la efectividad, costo-efectividad, calidad y adecuación cultural de las intervenciones del control de CRED.

7.4.2. La DIRESA/GERESA/DIRIS, y UE con establecimientos de salud que, en su cartera de servicios, incluyan el control de CRED, así como el Seguro Social de Salud (EsSalud), las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, e IPRESS privadas y mixtas; a través de su oficina de Recursos Humanos o equivalente, gestionan la inclusión en su Plan de Desarrollo de Personas (PDP) de un programa de capacitaciones para los profesionales de la salud que realizan el control de CRED.

7.4.3. El profesional de la salud que realiza el control de CRED participa activamente en los procesos de la capacitación y educación continua programados por su institución, manteniéndose actualizado en las mejores prácticas y la evidencia científica disponible para el control del CRED.

7.5. Gestión de la información

7.5.1. El profesional de la salud que realiza el control de CRED es responsable de registrar la atención de forma completa, precisa, legible y sin enmendaduras, inmediatamente después de finalizada. Este registro detalla todos los hallazgos y las acciones de la valoración, diagnóstico, intervención y seguimiento, garantizando la calidad de la información.

7.5.2. La jefatura de los establecimientos de salud públicos, mixtos o privados, que en su cartera incluyan el control de CRED, garantiza el uso y la disponibilidad de los siguientes instrumentos y sistemas para el registro del control de CRED:

- Historia Clínica (física o digital): El registro se realiza de manera ordenada, integrada y secuencial, según la NTS N° 139-MINSA/2018/DGAIN, Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica, aprobada por Resolución Ministerial N° 214-2018/MINSA (ver Anexo N° 19),

- Libreta de Cuidado Integral de Salud de la Niña y del Niño (física o digital): Se registra la información pertinente en este instrumento de uso compartido entre el profesional de la salud y las familias.

- Registro diario de atención (físico o digital): Se utiliza el sistema de información oficial de la institución (HIS-MINSA, sistemas de EsSalud, Sanidades, privados, etc.), empleando la codificación estandarizada vigente.

- Registros de seguimiento (físico o digital): Se utilizan para documentar las acciones de seguimiento.

- Registro de aseguramiento (físico o digital): Se completa la Ficha Única de Atención (FUA) u otro formato requerido por la institución administradora de fondos de aseguramiento en salud (IAFAS) para garantizar el financiamiento.

7.5.3. Cada establecimiento de salud público, mixto o privado que, en su cartera de servicios, incluya el control de CRED, es responsable de remitir la información consolidada de los controles de CRED a la oficina de Tecnologías de la Información o la que haga sus veces de manera completa y oportuna.

7.5.4. La DIRESA/GERESA/DIRIS, y UE con establecimientos de salud que, en su cartera de servicios, incluyan el control de CRED, así como el Seguro Social de Salud (EsSalud), las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, e IPRESS privadas y mixtas; son responsables de procesar, analizar y utilizar la información recopilada para el monitoreo, la evaluación, la planificación y la toma de decisiones estratégicas en su jurisdicción.

7.5.5. Adicionalmente, el Seguro Social de Salud (EsSalud), las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, así como los IPRESS privados y mixtos, remiten de forma periódica y obligatoria la información de los controles de CRED a la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del Ministerio de Salud.

7.6. Componente de financiamiento

7.6.1. El control de CRED en niños hasta los 11 años, 11 meses y 29 días constituye una prestación de salud y se encuentra incluida en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).

7.6.2. Toda institución administradora de fondos de aseguramiento en salud (IAFAS), pública, privada o mixta, garantiza la cobertura financiera integral del control de CRED, incluyendo las intervenciones, procedimientos, e insumos definidos en la presente Norma Técnica de Salud para su población asegurada.

7.6.3. La DIRESA/GERESA/DIRIS, y UE con establecimientos de salud que, en su cartera de servicios, incluyan el control de CRED, así como el Seguro Social de Salud (EsSalud), las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, e IPRESS privados y mixtos, son responsables de la gestión eficiente y transparente de los recursos asignados o recaudados para el control de CRED. Esto implica asegurar la correcta programación, ejecución y rendición de cuentas del presupuesto destinado a este fin, independientemente de la fuente de financiamiento.

7.6.4. En el caso de la DIRESA/GERESA/DIRIS, y la UE con establecimientos de salud que, en su cartera de servicios, incluyan el control de CRED, el financiamiento se estructura y ejecuta a través de las categorías presupuestales vigentes, priorizando el Programa Presupuestal Orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano (PPoR 1001-DIT) para los niños menores de 36 meses, y las Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP) para el resto de la población objetivo.

VIII. RESPONSABILIDADES

8.1. NIVEL NACIONAL

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, es responsable de la difusión de la presente Norma Técnica de Salud hasta el nivel regional, así como del monitoreo, supervisión, asistencia técnica y evaluación al nivel regional para su aplicación.

8.2. NIVEL REGIONAL

La GERESA, DIRESA y DIRIS de Lima Metropolitana; así como el Seguro Social de Salud (EsSalud), son responsables de la difusión de la Norma Técnica de Salud en su jurisdicción respectiva, así como del monitoreo, supervisión, asistencia técnica y evaluación para su implementación en los establecimientos de salud.

8.3. NIVEL LOCAL

La dirección o jefatura de cada establecimiento de salud, público o privado, según el nivel de complejidad, es responsable del cumplimiento de la presente Norma Técnica de Salud, en lo que corresponda.

IX. ANEXOS

- ANEXO N° 1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL CONTROL DE CRED.
- ANEXO N° 2 PAUTAS PARA APLICAR EL CONTROL DE CRED CON PERTINENCIA CULTURAL.
- ANEXO N° 3 CARACTERISTICAS DEL AMBIENTE Y LISTADO DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INSUMOS PARA EL CONTROL DE CRED Y SESIONES DE ATD
- ANEXO N° 4 LIBRETA DEL CUIDADO INTEGRAL DE SALUD DE LA NIÑA Y DEL NIÑO.
- ANEXO N° 5 FICHA PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA.
- ANEXO N° 6 FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN.
- ANEXO N° 7 GUÍA PARA EL EXAMEN FISICO.
- ANEXO N° 8 INSTRUMENTOS PARA LA DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL.
- ANEXO N° 9 RECOMENDACIONES PARA LA MEDICIÓN ANTROPOMÉTRICA E INTERPRETACIÓN DEL CRECIMIENTO.
- ANEXO N° 10 GUÍA DE PROCEDIMIENTO PARA LA VIGILANCIA Y TAMIZAJE DEL DESARROLLO INFANTIL.
- ANEXO N° 11 GUÍA DE PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN DEL TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA).
- ANEXO N° 12 PRINCIPIOS PARA REALIZAR LA DURANTE EL CONTROL DE CRED.
- ANEXO N° 13 INSTRUCTIVO DE USO DEL KIT DEL BUEN CRECIMIENTO INFANTIL.
- ANEXO N° 14 PAUTAS PARA LA CONSEJERÍA EN DESARROLLO INFANTIL DURANTE EL CONTROL DE CRED.
- ANEXO N° 15 SUPLEMENTACIÓN PREVENTIVA DE VITAMINA A NIÑOS DE 6 A 59 MESES.
- ANEXO N° 16 PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE ATENCIÓN TEMPRANA DEL DESARROLLO (ATD).
- ANEXO N° 17 CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN.
- ANEXO N° 18 TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DURANTE LOS CONTROLES DE CRED, SEGÚN EDAD Y CONTROL.
- ANEXO N° 19 FORMATO DE HISTORIA CLÍNICA.

X. BIBLIOGRAFÍA

1. Raineri, F., et al., *Determinantes sociales y ambientales para el desarrollo de los niños y niñas desde el período del embarazo hasta los 5 años*, ed. UNICEF. 2015, Argentina: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

2. Walker, S.P., et al., *Inequality in early childhood: risk and protective factors for early child development.*Lancet, 2011. **378**(9799): p. 1325-38.

3. Grantham-McGregor, S., et al., *Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries.* Lancet, 2007. **369**(9555): p. 60-70.

4. MINSA, Directiva Sanitaria para la Detección Temprana y Atención de Cáncer en el Niño y Adolescente, aprobada por Resolución Ministerial N°149-2020/MINSA.

5. WHO, *Meeting report: nurturing human capital along the life course: investing in early child development*, WHO, Editor. 2013, WHO: Geneva, Switzerland.

6. Irwin, L., A. Siddiqi, and C. Hertzman, *Desarrollo de la primera infancia: un potente ecualizador.* 2007.

7. Olds, D.L., L. Sadler, and H. Kitzman, *Programs for parents of infants and toddlers: recent evidence from randomized trials.*J Child Psychol Psychiatry, 2007. **48**(3-4): p. 355-91.

8. INEI. *Encuesta demográfica y de salud familiar, 2009* 2009, Available from: http://proyectos.inei.gob.pe/endes/endes2009/resultados/.

9. INEI. *Encuesta demográfica y de salud familiar, 2015 - 1.* 2015, Available from: http://www.app.minsa.gob.pe/bsc/detalle_indbsc.asp?Icind=85&Icobj=1&Icper=1&Icfreq=14/10/2015.

10. Engle, P.L., et al., *Strategies for reducing inequalities and improving developmental outcomes for young children in low-income and middle-income countries.*Lancet, 2011. **378**(9799): p. 1339-53.

11. Cusminsky, M., et al., *Manual del crecimiento y desarrollo del niño*, ed. PALTEX. Vol. 33. 1994, Washington, D.C. 20037, E.U.A.: Organización Panamericana De La Salud.

12. MINSA, Esquema del Desarrollo del Niño, Instituto Nacional de Rehabilitación.1996, Lima,Perú

13. Figueiras, A., et al., *Manual para la vigilancia del desarrollo infantil en el contexto de AIEPI.* 2006, Washington, D.C: EEUU: OPS.

14. WHO. *Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. Subsanar las desigualdades en una generación. Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud.* 2009, Available from: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789243563701_spa.pdf.

15. Sierra, L., *Promoción del crecimiento y desarrollo en la primera infancia. Buenas prácticas y lecciones aprendidas del programa buen inicio*, ed. UNICEF. 2011, Lima, Perú.

16. Cunha, H., et al., *Interpreting the evidence on life cycle skill formation. Handbook of the Economics of Education.* Handbook of the Economics of Education, ed. E. B.V. Vol. 1. 2006.

17. Needlman, R., et al., *Effectiveness of a primary care intervention to support reading aloud: a multicenter evaluation.*Ambul Pediatr, 2005. **5**(4): p. 209-15.

18. UNICEF. *Estado Mundial de la Infancia 2008: Supervivencia Infantil.* 2008, Available from: en: http://www.unicef.org/spanish/publications/files/Estado_mundial_de_la_infancia_2008.pdf.

19. Oliver, M., *Diagnóstico Precoz en Salud Mental Pediátrica.* Vol. Ensayos sobre crecimiento y desarrollo, presentado al Doctor Horacio Lajarraga por sus colegas y discípulos. 2011, Buenos Aires.

20. Barker, D.J., *The developmental origins of well-being.* Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 2004. **359**(1449): p. 1359-66.

21. *The Child Abuse Prevention and Treatment Act. Including Adoption Opportunities & The Abandoned Infants Assistance.* 2010, Available from:http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/cb/capta2010.pdf.

22. Selph, S.S., et al., *Behavioral interventions and counseling to prevent child abuse and neglect: a systematic review to update the US Preventive services task force recommendation.* Ann Intern Med, 2013. **158**(3): p. 179-90.

23. Daelmans, B., et al., *Effective interventions and strategies for improving early child development.*BMJ, 2015. **351**: p. h4029.

24. MINSA, *Guía de práctica clínica para la detección, diagnóstico, tratamiento y control de errores refractivos en niñas y niños mayores de 3 años y adolescentes.* 2014: Perú.

25. AAO. *Pediátrica y Estrabismo. Patrones de Prácticas Preferentes Lineamientos. Evaluación Ocular Pediátrica.* 2007, Available from: http:www.aao.org/ppp.

26. Fescina, R., et al., *Manual de Autoinstrucción: Vigilancia del Crecimiento Fetal.* Publicación Científica CLAP ed. 2011, Montevideo, Uruguay: Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud.

27. OMS. *Patrones de crecimiento infantil.* 2006, Available from: http://www.who.int/childgrowth/standards/es/.

28. MINSA, *Directiva sanitaria que establece la suplementación con multimicronutrientes y hierro para la prevención de anemia en niñas y niños menores de 36 meses.* 2014.

29. MINSA, *NORMA TECNICA DE SALUD N° 113-MINSA/DGIEM-V.01. Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención.* 2015, Dirección general de infraestructura, equipamiento y mantenimiento.

30. Asociación Latinoamericana de Odontopediatría (ALOP). Folletos Educativos. Disponible en URL: http://www.revistaodontopediatria.org/publicaciones/ [Accedido 1 de Febrero 2017]

31. Santos AP, Nadanovsky P, Oliveira BH. A systematic review and meta-analysis of the effects of fluoride toothpastes on the prevention of dental caries

32. in the primary dentition of preschool children. Community Dent Oral Epidemiol 2013,41(1):1-12

33. Walsh T, Worthington HV, Glenny AM, Appelbe P, Marinho VC, Shi X. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2010, Issue 1.

34. American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on perinatal and infant oral health care. Pediatr Dent Reference Manual 2016-17,38(6):150–54.

35. Clark MB, Slayton RL, Section on Oral Health. Fluoride use in caries prevention in the primary care setting. Pediatrics 2014, 134(3): 626-33.

36. MINSA. Directiva Sanitaria para el cuidado integral de salud mental de gestantes y madres de niñas y niños menores de 5 años. Directiva Sanitaria N° 155-MINSA/DGIESP-2024.

37. MINSA. Modificatoria de la Directiva Sanitaria para el cuidado integral de salud mental de gestantes y madres de niñas y niños menores de 5 años. Resolución Ministerial N° 431-2024/MINSA.

38. Huanca, D. (2023). **Guía de Vigilancia del Neurodesarrollo. Manual de Aplicación**. Fondo Editorial IIDENUT S.A.

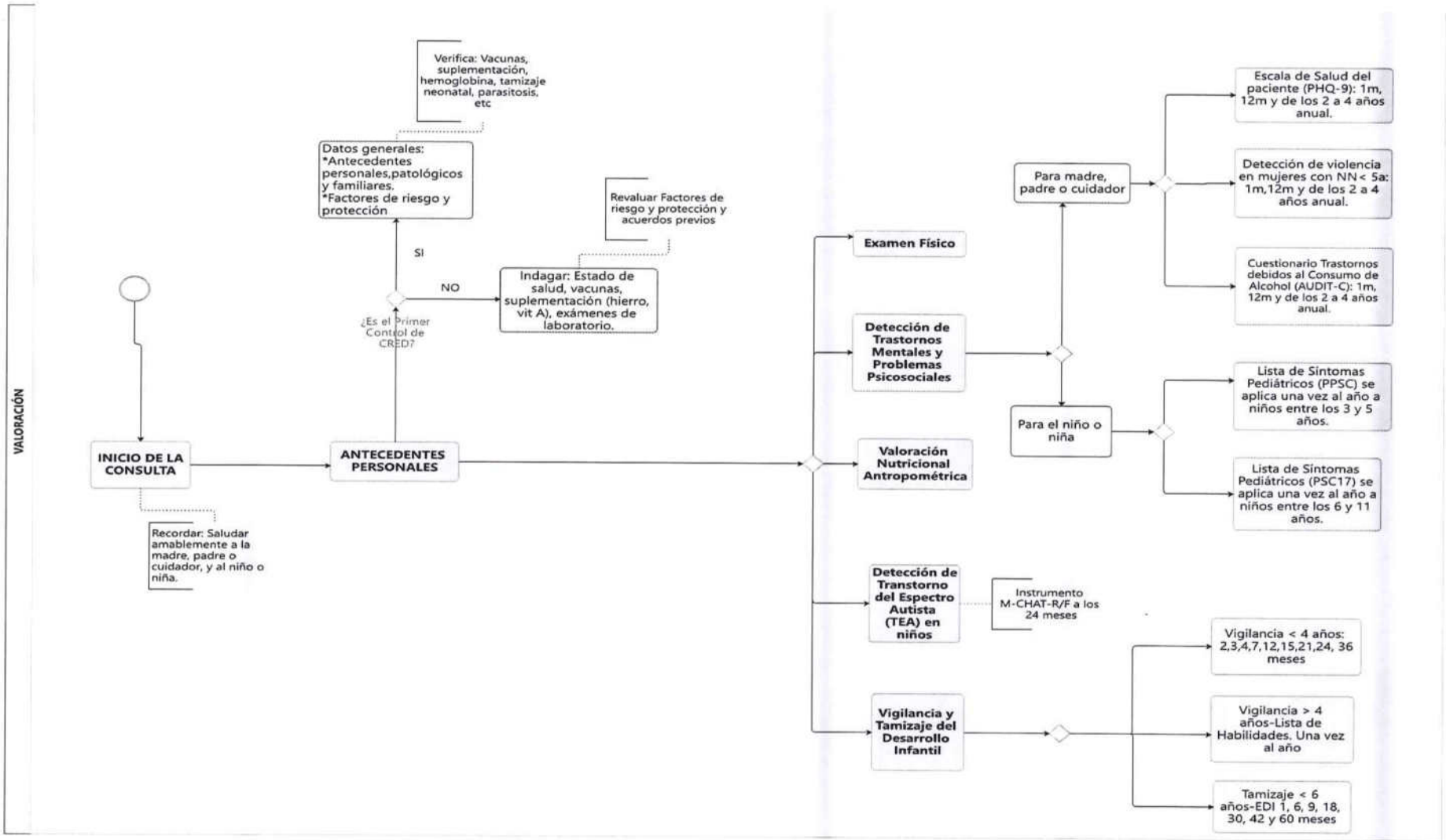
39. Organización Mundial de la Salud & UNICEF. (2009). *Visitas domiciliarias al recién nacido: una estrategia para aumentar la supervivencia*. Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO_FCH_CAH_09.02.

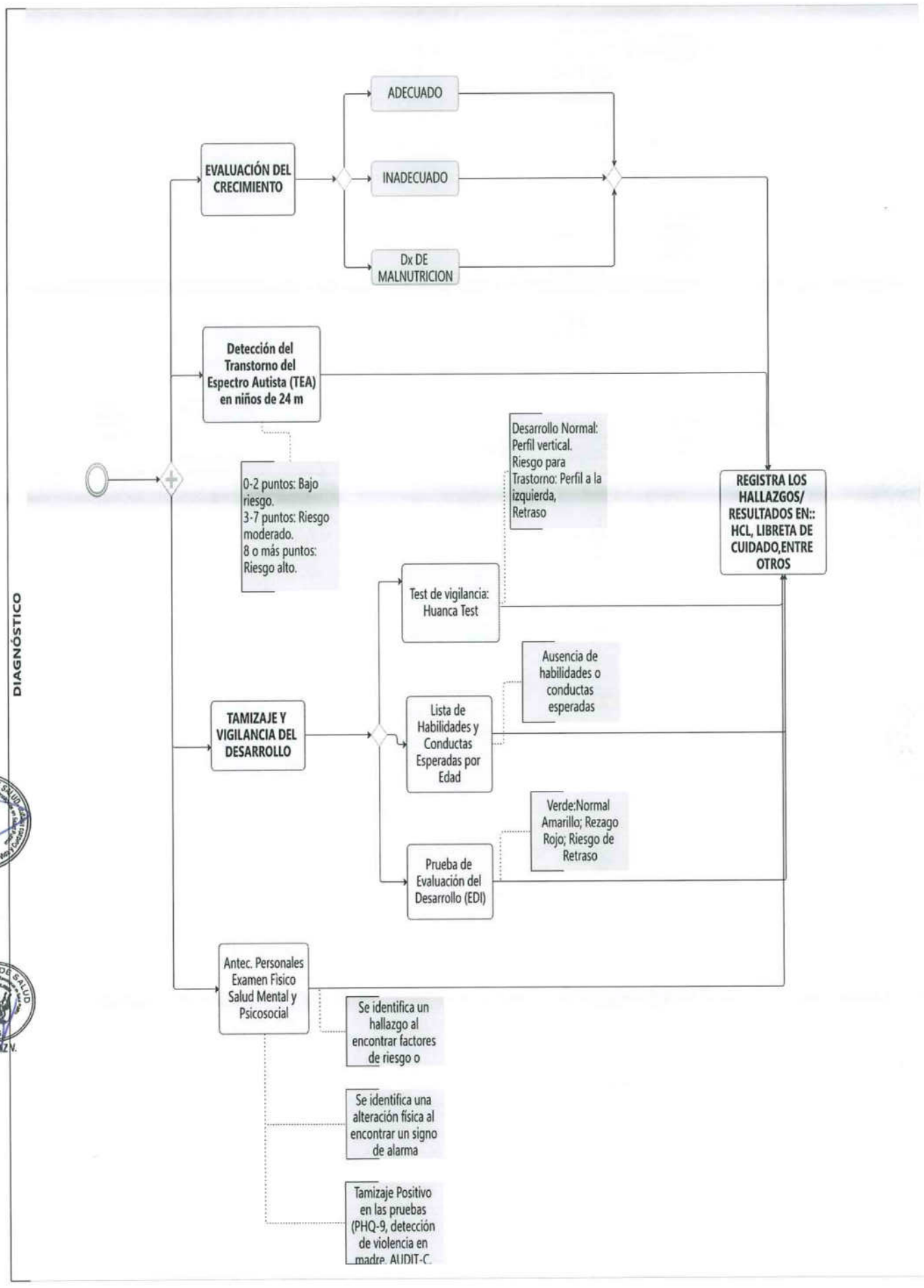
40. Cortez-Vergara, C. P., Hijar-Guerra, G., Távara-Campos, B., & Ugaz-Villacorta, M. E. (2022). Initial steps in the selection of a child development screening instrument in the peruvian context. Boletín Médico Del Hospital Infantil De México, 82(Supl. 1), 25–34.

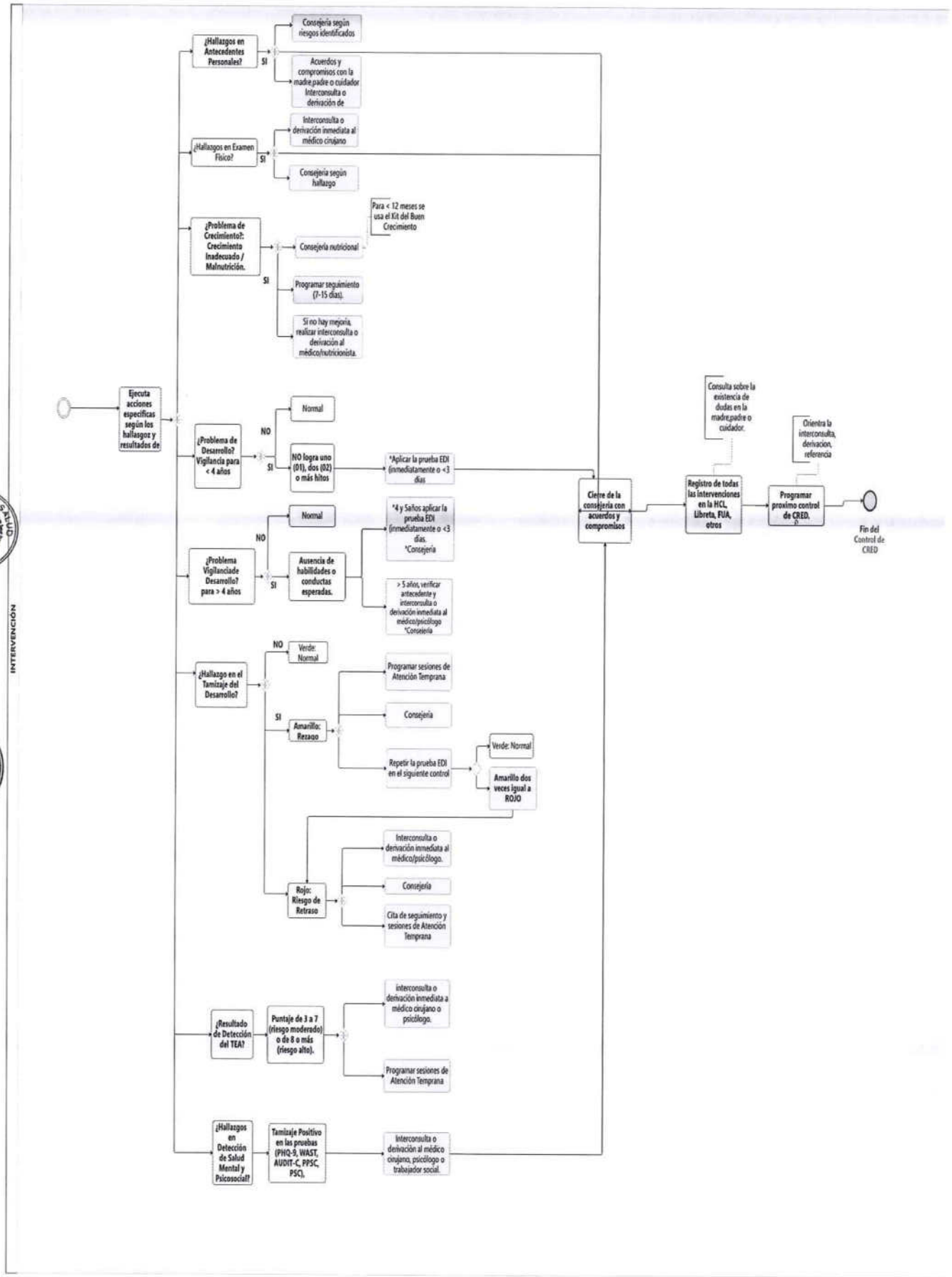
41. Organización Mundial de la Salud. (2001). Intervención breve para el consumo de riesgo y perjudicial de alcohol: Un manual para la utilización en atención primaria. https://www.who.int/substance_abuse/publications/alcohol/en/

42. Ministerio de Salud. (2021). Norma Técnica para la Supervisión de Salud Integral de Niños y Niñas de 0 a 9 Años en la Atención Primaria de Salud - Actualización 2021. Gobierno de Chile. https://bibliotecadigital.minsal.cl/handle/2015/4079

ANEXO N° 1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL CONTROL DE CRED



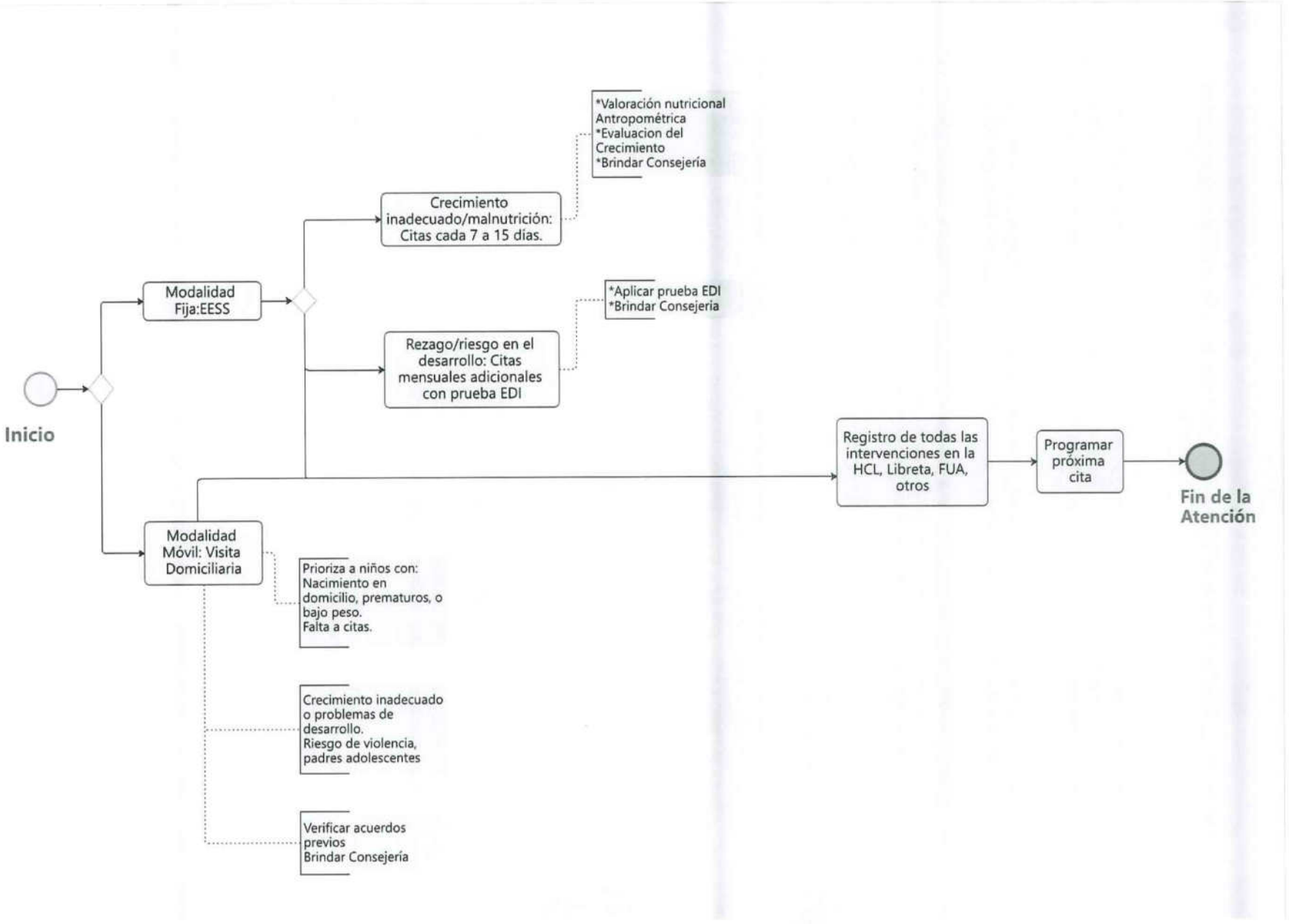

DIAGNÓSTICO
EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO
ADECUADO
INADECUADO
Dx DE MALNUTRICION
Detección del Transtorno del Espectro Autista (TEA) en niños de 24 m
0-2 puntos: Bajo riesgo.
3-7 puntos: Riesgo moderado.
8 o más puntos: Riesgo alto.
Desarrollo Normal: Perfil vertical.
Riesgo para Trastorno: Perfil a la izquierda, Retraso
REGISTRA LOS HALLAZGOS/ RESULTADOS EN:: HCL, LIBRETA DE CUIDADO,ENTRE OTROS
TAMIZAJE Y VIGILANCIA DEL DESARROLLO
Test de vigilancia: Huanca Test
Lista de Habilidades y Conductas Esperadas por Edad
Ausencia de habilidades o conductas esperadas
Prueba de Evaluación del Desarrollo (EDI)
Verde:Normal Amarillo; Rezago Rojo; Riesgo de Retraso
Antec. Personales Examen Fisico Salud Mental y Psicosocial
Se identifica un hallazgo al encontrar factores de riesgo o
Se identifica una alteración física al encontrar un signo de alarma
Tamizaje Positivo en las pruebas (PHQ-9, detección de violencia en madre, AUDIT-C,



MINISTERIO DE SALUD
C. DIAZ V.

MINISTERIO DE SALUD
M.C. EMILIO ALBANO CARRASCO
V°B°

SEGUIMIENTO



ANEXO N° 2: PAUTAS PARA APLICAR EL CONTROL DE CRED CON PERTINENCIA CULTURAL

Para que el control de CRED integre el enfoque intercultural, se ofrece tomando en cuenta las características culturales de la población. Para adaptar sus procesos a las características geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales, se debe considerar lo siguiente:

- Saludo y la interacción: El profesional de la salud debe utilizar frases sencillas y afines a las que usa la población, para generar empatía y mejorar la calidad de la atención.

- Infraestructura: La sala de espera y el consultorio del control de CRED deben ser adecuados con elementos relevantes de la población local, como sillas de madera, mantas, imágenes o señalética en lengua original.

- Capacitación: El personal debe recibir formación sobre el enfoque intercultural, la población indígena de la jurisdicción, sus lenguas originarias, costumbres, creencias y formas de vida.

- Gestión de la información: Se deben crear mecanismos para obtener información sobre costumbres y creencias que influyen en el crecimiento y desarrollo del niño. Esto debe incorporarse en los análisis situacionales de salud o a través de investigaciones.

- Materiales e instrumentos: Los materiales educativos e instrumentos deben tener una adecuación cultural en su diseño e imágenes, especialmente los usados para consejerías, visitas domiciliarias, sesiones de atención temprana, el Kit del Buen Crecimiento y los registros como la Libreta de Cuidado Integral de Salud de la Niña y del Niño.

- Validación e integración de conocimientos y prácticas tradicionales: El profesional de la salud debe validar y respetar las prácticas de crianza, alimentación y cuidado propias de la cultura local. Siempre que sean seguras y no representen un riesgo para el niño, se deben integrar en la consejería y los acuerdos de atención, reconociendo el saber ancestral de la madre, padre o cuidador principal.

- Temas comunicacionales: Se generan estrategias y campañas comunicacionales con mensajes clave sobre el crecimiento y desarrollo en lenguas originarias, considerando costumbres y creencias.

ANEXO N° 3: CARACTERISTICAS DEL AMBIENTE Y LISTADO DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INSUMOS PARA EL CONTROL DE CRED Y SESIONES DE ATD

El Anexo establece el estándar técnico obligatorio que la jefatura de cada establecimiento de salud debe cumplir para el diseño, organización y **dotación** de los ambientes y equipamiento destinados al control de CRED y a las Sesiones de Atención Temprana del Desarrollo (ATD).

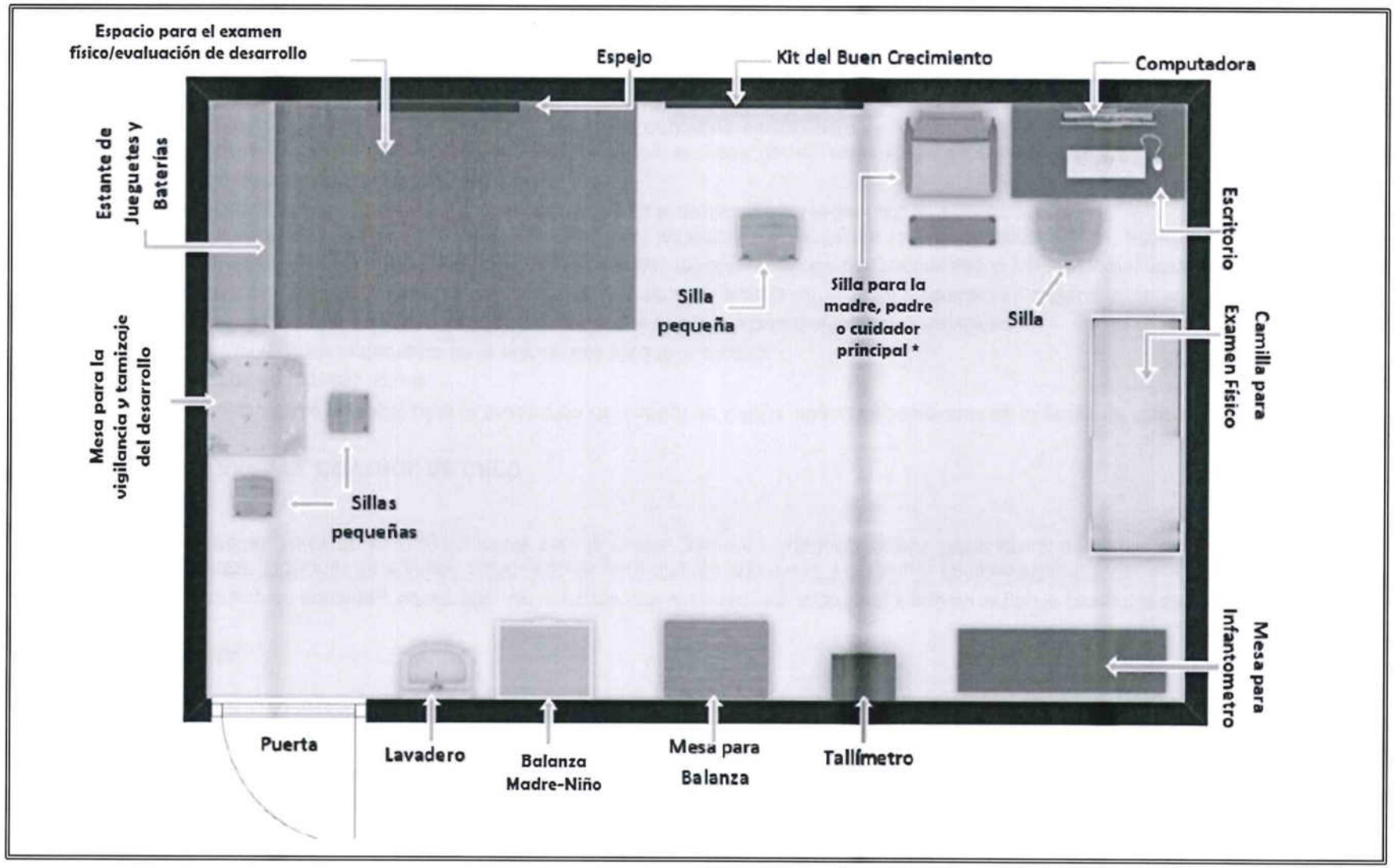
1. CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE Y ESPACIOS FÍSICOS

A. SALA DE ESPERA

- Función: Espacio de acogida y educación. Debe contar con dimensiones, mobiliario y equipo según la categoría del establecimiento.
- Requerimientos: Disponer de equipos audiovisuales para difundir información de salud, paneles informativos ordenados y material escrito (trípticos, cartillas, libros de lectura) accesible para la madre, padre o cuidador principal. Debe ser un ambiente seguro y acogedor para los niños.

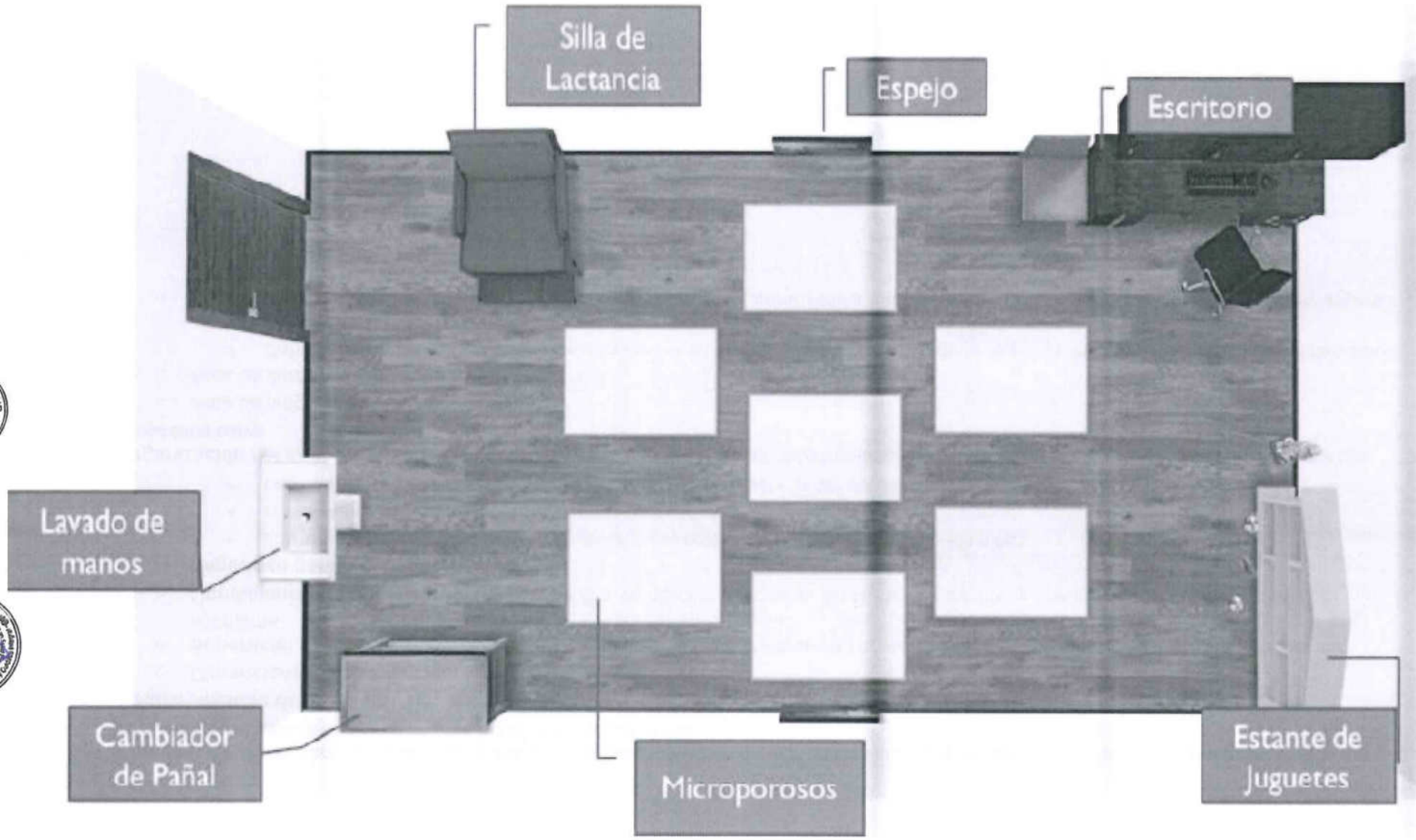
B. CONSULTORIO PARA EL CONTROL DE CRED

- Función: Espacio físico principal para la realización del control de CRED, según disposiciones de la presente Norma Técnica de Salud.
- Requerimientos de Infraestructura:
  - Ubicación: Preferentemente en la planta baja y de fácil acceso.
  - Dimensiones: Área mínima de 17 m², que permita una adecuada distribución y movilidad.
  - Condiciones: Debe garantizar privacidad, confort térmico, buena iluminación y ventilación. Evitar alfombras o pisos porosos.
  - Seguridad: Tomacorrientes con protección especial, mobiliario con bordes redondeados y puertas con protectores.
  - Instalaciones: Debe contar obligatoriamente con instalaciones sanitarias (lavadero funcional con acceso a agua y desagüe) e instalaciones eléctricas seguras y suficientes para el equipamiento requerido.
- Organización del espacio:
  - **Entorno Libre de Distracciones:** Las paredes y el techo deben estar libres de afiches, juguetes colgantes (móviles) u otros elementos visuales que no tengan un propósito educativo directo para el control. El objetivo es crear un ambiente que facilite la concentración del niño y la objetividad en la evaluación del desarrollo.
  - A continuación, se inserta la imagen del ***plano referencial*** del consultorio. Su función es ilustrar una organización óptima del espacio y el mobiliario.


Espacio para el examen físico/evaluación de desarrollo
Espejo
Kit del Buen Crecimiento
Computadora
Estante de Juguetes y Baterías
Escritorio
Silla pequeña
Silla para la madre, padre o cuidador principal *
Silla
Camilla para Examen Físico
Mesa para la vigilancia y tamizaje del desarrollo
Sillas pequeñas
Mesa para Infantometro
Puerta
Lavadero
Balanza Madre-Niño
Mesa para Balanza
Tallímetro

C. AMBIENTE PARA SESIONES DE ATENCIÓN TEMPRANA (ATD)

- **Función:** Espacio físico diseñado para la ejecución segura y efectiva de actividades grupales de juego, exploración e interacción. Puede ser un área de uso exclusivo o un ambiente multifuncional adaptable.
- **Requerimientos de infraestructura y seguridad:**
  - **Dimensiones:** Debe contar con un área mínima de 24 m².
  - **Superficie:** El suelo debe ser seguro, sin desniveles, y de un material no poroso y lavable (ej. piso microporoso). Evitar el uso de alfombras.
  - **Condiciones ambientales:** Buena iluminación, ventilación adecuada, sin corrientes de aire, y una temperatura confortable.
  - **Seguridad general:**
    - Los tomacorrientes deben tener protección especial y no estar al alcance de los niños.
    - El mobiliario debe tener puntas y aristas protegidas.
    - Las puertas deben contar con sistemas de protección para evitar accidentes.
- **Organización del espacio (diseño funcional):** El ambiente debe contar obligatoriamente con espacios diferenciados y equipados para dos propósitos clave:
  - Área de juego y movimiento.
  - Área de cuidados cotidianos:
    - Debe contar con el mobiliario necesario para la lactancia (silla cómoda, banquito, cojines), el cambio de pañal y la alimentación complementaria.
  - *A continuación, se inserta la imagen del **plano referencial del consultorio**. Su función es ilustrar una organización óptima del espacio y el mobiliario.*


Silla de Lactancia
Espejo
Escritorio
Lavado de manos
Cambiador de Pañal
Microporosos
Estante de Juguetes

2. PREPARACIÓN OBLIGATORIA DEL AMBIENTE ANTES DE LA ATENCIÓN

Antes de cada jornada de atención (sea para control de CRED o sesiones de ATD grupales), el profesional de la salud es responsable de asegurar las siguientes condiciones:

- Preparación física: El ambiente y todos los materiales deben estar preparados y ordenados con anticipación, asegurando que estén limpios, funcionales y dispuestos de manera que faciliten la actividad.
- Coordinación de espacios: Si el ambiente es de uso compartido (sólo para el caso de las ATD), el profesional de la salud debe realizar las coordinaciones previas para evitar interrupciones y garantizar la exclusividad del espacio durante la sesión.
- Orientación a la familia: Al inicio de la atención, el profesional de la salud orienta a la madre, padre o cuidador sobre la disposición de los espacios (zona de juego, zona de cuidado) y los tiempos.

3. RECURSOS HUMANOS:

La jefatura de cada establecimiento de salud, público, privado o mixto, gestiona la disponibilidad del recurso humano calificado (profesional licenciado en enfermería o médico cirujano), quien es el responsable de la correcta utilización del ambiente, equipo, mobiliario e insumos.

4. LISTADO DE EQUIPOS, MOBILIARIOS E INSUMOS:

Clasificación	Nombre del Insumo/Equipo/Mobiliario	Clasificación	Nombre del Insumo/Equipo/Mobiliario
Insumos - Formatos	Libreta de Cuidado Integral de Salud de la Niña y del Niño	Equipos - Médicos	Oftalmoscopio directo.
	Cartilla de Snellen.		Pantoscopio pediátrico.
	Cartilla "El Camino del Buen Crecimiento"- Niño y Niña.		Otoscopio
	Lámina "El Camino del Buen Crecimiento"- Niño y Niña.		Estetoscopio
	Formato de Atención SIS.		Tensiómetro
	Formato de Referencia SIS.		Oxímetro de pulsos neonatal.
	Formato pre-impreso de historia clínica.		Termómetro de uso médico.

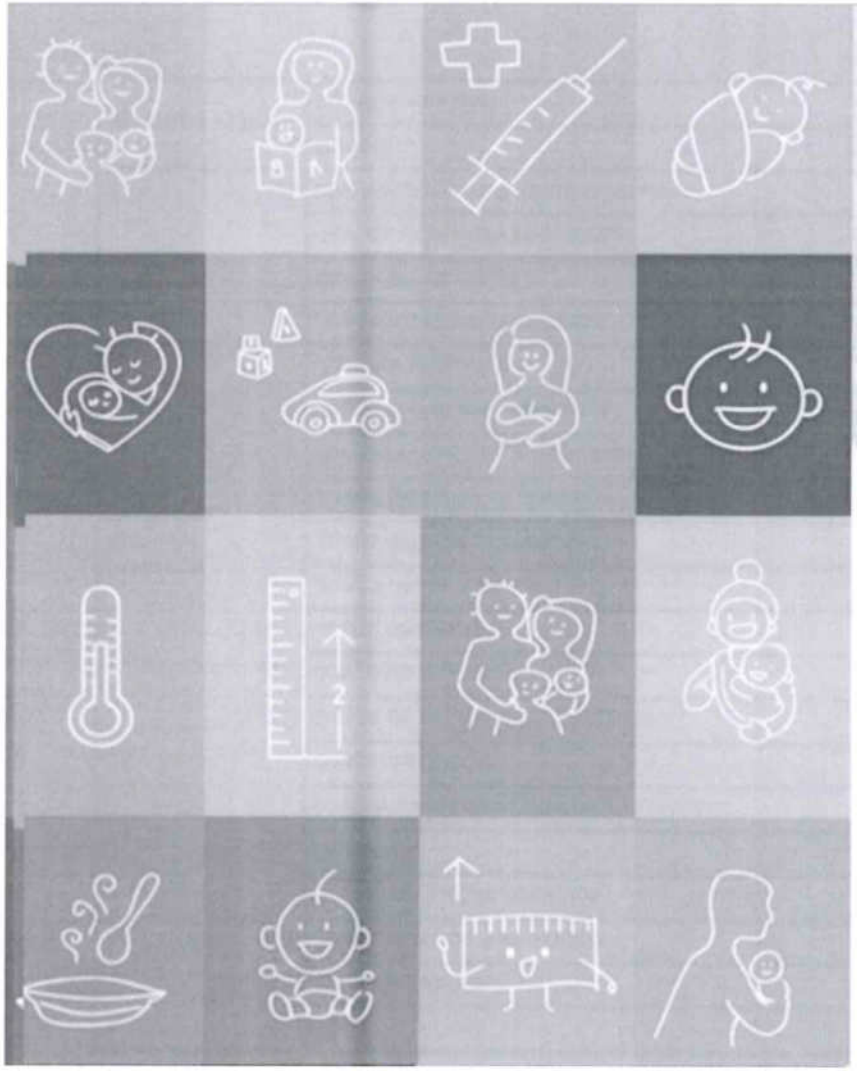
	Formato Registro Diario de Atención HIS MIS.		Estufa/calefacción (zona de bajas temperaturas).
	Formato Solicitud de Análisis de Laboratorio.		Balanza (de pie madre-niño, digital, pediátrica).
	Formatos de las Pruebas de Vigilancia, Tamizaje y TEA		Infantómetro
	Formatos administrativos impresos.		Tallímetro
	Trípticos	**Equipos - Cómputo y Periféricos**	Equipo multifuncional.
	Gigantografía		Impresora
	Láminas para rotafolio.		Monitor
Insumos - Material de oficina	Archivador de plástico de palanca, bolígrafo/lapicero, borrador, cinta de papel para enmascarar, clips, corrector líquido, engrapadora, fechadores, folder manila, grapas, lápices, organizadores multiusos, papel bond, papel carbón, perforador, plumones, memorias portátiles, protector y porta documentos, regla, sacagrapas, sobre en general, sujetadores para papel, tajadores, tampón, tinta para tampón, tóner de impresión.		Teclado
Insumos - Materiales Médicos y de Laboratorio	Mascarilla descartable.		CPU
	Guante para examen descartable.		Mouse óptico.
	Mandil/mandilón descartable.		Televisor
	Alcohol isopropílico.		Equipo de sonido.
	Jabón germicida líquido.		Linterna
	Desinfectante amonio cuaternario.		Pila
	Toalla antiséptica.		Estabilizador
	Sabanilla de papel para camilla.	**Mobiliario - De Oficina**	Escritorio de melamine/madera.
	Bajalengua		Estante de melamine/madera.
	Cinta métrica de teflón.		Silla giratoria, con brazos (ergonómica).
	Esparadrapo antialérgico.		Sillón fijo.
	Gasa estéril.		Mesa de madera para infantómetro/balanza pediátrica.
	Linterna para examen médico.		Pizarra acrílica.
	Martillo de percusión.		Rotafolio

	Tijera		Rack
	Algodón hidrófilo.	**Mobiliario - Médico**	Camilla
	Termómetro de uso médico.		Coche metálico.
Insumos - Material Didáctico	Balde con juegos creativos.		Mesa para cambiar pañales.
	Cuchara		Podoscopio
	Evaluaciones psicológicas, psicomotriz.	**Mobiliario - Para Niños y Recreación**	Mesita de madera para niños.
	Juego de carros.		Silla fija de melamina para niño.
	Juego de coladores/jarra/tazones.		Juego recreativo.
	Juego de muñecos.		Colchoneta
	Juego de pelotas.		Tarima con barandillas.
	Juego de verduras.		Juego de pisos de microporoso.
	Juego didáctico de encaje.	**Mobiliario - Otros**	Baldes y similares.
	Juego didáctico de pasado.		Bidón
	Juegos didácticos y similares.		Espejo decorativo.
	Juguete animales de granja.		Tachos
	Juguete ollas de plástico.		Caja de bioseguridad.
	Juguete vajillas de plástico.	**Suministros para Mantenimiento de Equipo Médico**	Juego de pesa patrón.
	Muñecas educativas.		Waype
	Test de desarrollo psicomotor.		Lija
	Mochila acolchada porta tallímetros.		Destornillador o herramientas de ajuste.
Insumos - Otros	Panera		Cera
	Pasta limpia tipos.	**Servicios**	Servicio de diseño, diagramación e impresión.





ANEXO N° 4 LIBRETA DEL CUIDADO INTEGRAL DE SALUD DE LA NIÑA Y DEL NIÑO







Mis Datos Personales

Nombres y apellidos

DNI/CE/pasaporte CNV

Nro. Historia clínica

EE.S.S. donde me atiendo:

Tipo de seguro SIS ESSALUD EPS Sanidad Militar Otros

Sexo F M

Lugar de nacimiento

Distrito Provincia

Departamento Pais

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

¿Pertenezco a una comunidad indígena? SI NO

¿Cuál?

Celular

¿Estoy en algún programa social o guardería? SI NO

¿Cuál? CUNA MÁS JUNTOS Guardería particular

Alergias

Datos de mis padres

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE

DNI/Carné de extranjería/pasaporte Fecha de nacimiento Grupo sanguíneo

Nacionalidad Nivel de instrucción

Ocupación ¿Vive con el niño o niña? SI NO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE

DNI/Carné de extranjería/pasaporte Fecha de nacimiento Grupo sanguíneo

Nacionalidad Nivel de instrucción

Ocupación ¿Vive con el niño o niña? SI NO

¿Alguna otra persona me cuida? SI NO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL CUIDADOR

DNI/Carné de extranjería/pasaporte Fecha de nacimiento Grupo sanguíneo

Nacionalidad Nivel de instrucción

Ocupación ¿Vive con el niño o niña? SI NO

Relación con el niño o niña

Lugares y teléfonos importantes

Centro de Salud

Hospital de referencia

Policía nacional	Infosalud	Defensa civil	Bomberos	Central de emergencias
105	113	115	116	911

MINISTERIO DE SALUD
M.C. 2016
EMILIO ALDANA CARRASCO
VºBº

MINISTERIO DE SALUD
C. DIAZ V.

Mis derechos

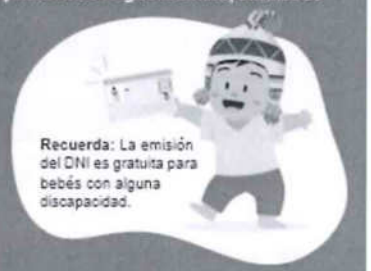
- ✓ A conocer a mis padres y vivir con ellos salvo que no sea lo mejor para mí.
- ✓ A mantener el contacto y a reunirme con mis dos padres, aunque estén separados.
- ✓ A obtener la información adecuada, expresar mi opinión y que la tengan en cuenta. A
- ✓ mi privacidad o a disfrutar de la compañía de otros niños y niñas.
- ✓ A ser protegido del abuso o negligencia.
- ✓ A recibir una atención en salud y educación con calidad aun si tengo alguna discapacidad.
- ✓ A recibir cuidados especiales, educación y capacitación si tengo alguna discapacidad en atención a mis talentos y personalidad.
- ✓ A jugar, descansar y participar de actividades recreativas.
- ✓ A ser protegido de cualquier forma de explotación, castigo, trato inhumano, abuso y tráfico ilegal.
- ✓ A ser protegido de los conflictos armados.
- ✓ A ser protegido de la pornografía y otras formas de manipulación digital.
- ✓ A recibir la debida ayuda y rehabilitación si se violaron mis derechos.

Derecho a tener una identidad

Tener un nombre y una identidad me permite ser reconocido y parte de la sociedad. Para ello, es fundamental tener un Documento Nacional de Identidad (DNI). Para obtenerlo, el declarante (madre, padre, hermano mayor o tutor legal) inicia el trámite.

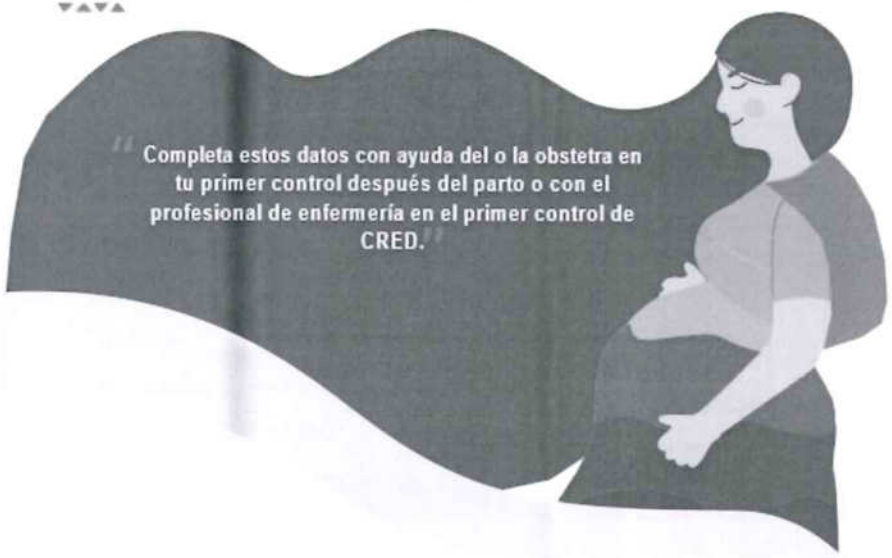
Requisitos y consideraciones:

- Cuando tienes un bebé, hay que seguir algunos pasos básicos para que tu niña o niño pueda disfrutar de todos los beneficios de un ciudadano peruano.
- Primero, el recién nacido debe ser registrado gratuitamente en el establecimiento de salud donde se atendió el parto. De esta manera, se genera el Certificado de Nacido Vivo (CNV), que identifica a la madre y al profesional que atendió el parto o cesárea. Este certificado es el requisito básico para conseguir el Acta de Nacimiento y la inscripción de la niña y niño en los Registros Civiles, además de permitir que pueda obtener su DNI posteriormente.
- Si tu bebé tiene alguna discapacidad, presenta cualquiera de los siguientes documentos:
  - Certificado de Discapacidad.
  - Resolución Ejecutiva de CONADIS.
  - Certificado o Constancia del Centro de Educación Especial.



Recuerda: La emisión del DNI es gratuita para bebés con alguna discapacidad.

Datos del embarazo



"Completa estos datos con ayuda del o la obstetra en tu primer control después del parto o con el profesional de enfermería en el primer control de CRED."

Número de controles prenatales			
Factores de riesgo en el embarazo:	SI	NO	Observaciones
Infecciones urinarias recurrentes, sangrados u otras enfermedades durante el embarazo			
Circular de cordón durante el parto y/o demoró mucho en llorar al nacer			
Preeclampsia.			
Eclampsia			
Edad materna menor a 16 años.			
Otros			

Datos de mi nacimiento

Recuerda que estos datos serán llenados por el profesional de salud antes del alta o en tu primer control de crecimiento y desarrollo.

Nací a las ____ semanas

¿Nací en un centro de salud u hospital? SI NO ¿Cuál fue?
¿El parto fue normal o complicado? Normal Complicado Peso al nacer ____ Kg

Talla al nacer ____ cm APGAR 1 min ____ 5 min ____

P. Toráxico ____ cm P. cefálico ____ cm Grupo sanguíneo y RH ____

Problema de salud importante ____

Problemas de salud en la familia ____

Contacto piel a piel por 60 min SI NO Lactancia en la primera hora SI NO

UCI neonatal mayor a 4 días SI NO Reanimación al nacer SI NO

Tamizaje Neonatal

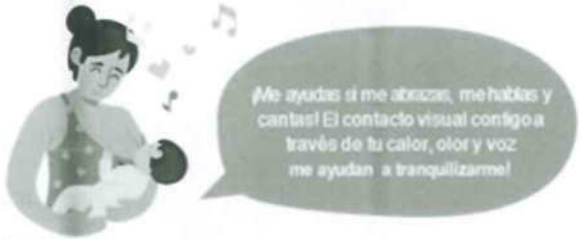
METABÓLICO			CARDIACO	AUDITIVO	VISUAL
Fecha			Fecha	Fecha	Fecha
Hipotiroidismo congénito	+	-	Resultado	Resultado	Resultado
Hiperplasia suprarrenal	+	-	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Fenilcetonuria	+	-			
Fibrosis quística	+	-			
Firma y sello	Firma y sello		Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello

¡Mamá y papá no se olviden de preguntar al profesional de la salud sobre mis resultados de tamizaje

¿Qué debes saber sobre mi cuidado al nacer?



- Es normal que la leche demore unos días en aparecer.
- La lactancia es un proceso natural. Tu primera leche se llama calostro, una vacuna que me protege contra varias enfermedades.
- Ofréceme el pecho frecuentemente.
- Es aconsejable cambiar de posición y cuidar que mi boquita esté bien agarradita a tu pecho, tomando toda la aréola, así no sentirás dolor ni aparecerán grietas.
- La leche materna es el alimento natural e insuperable para mí y debe ser mi único alimento hasta llegar a los 6 meses.



Recuerda siempre:

- Lavarte las manos antes de lactar y después de cambiarme el pañal, tocar objetos, superficies contaminadas, residuos sólidos o dinero.
- Acostarme siempre en posición boca arriba para dormir y cubrirme solo hasta la altura de mis hombros.
- Hasta que mi ombligo se caiga debe estar por fuera del pañal. Limpia mi ombligo con frecuencia siguiendo las indicaciones del personal de salud.
- Cumplir con todas mis vacunas.

Y evita:

- Que muchas personas me carguen y den besos, sobre todo si están resfriadas.
- Fumar en la casa.
- Acostarme en un colchón blando ni almohada porque me puedo asfixiar.

Controles de crecimiento y desarrollo (CRED)

Mis primeros dos años de vida son claves en el desarrollo de mi cerebro y mi crecimiento físico, por ello necesito, mucho amor, afecto, seguridad de las personas que están a cargo de mi cuidado.

Es indispensable que me lleves a todos mis controles de CRED para vigilar mi adecuada ganancia de peso, talla y habilidades para mi edad. Así prevenimos posibles problemas a tiempo.

También verificarán si tengo mis vacunas completas de acuerdo al esquema y solicitarán el tamizaje de anemia y parasitosis de acuerdo a lo que corresponde

Sí tienes alguna duda consulta con el profesional de la salud.

Frecuencia

3 Controles:
1° Entre las 48 horas del alta hasta los 7 días
2° Entre los 8 días hasta los 14 días
3° Entre los 15 días hasta los 21 días



Recién nacido

7 Controles:
1m, 2m, 3m, 4m, 6m, 7m y 9m



1 a 11 meses

4 Controles:
cada 3 meses



12 a 23 meses

2 Controles:
cada 6 meses



24 a 59 meses

1 control anual



5 a 11 años

Recuerda: A partir de los 5 años hasta los 11 años sigue llevándome al CRED una vez al año

¿¿Cómo va mi crecimiento?

En esta sección está toda la información sobre cómo voy creciendo. Esto es importante para prevenir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad y crecer fuerte y saludable.

Nro. de control	Fecha	Edad	Peso	Talla	P. Cefálico	IMC	Observaciones

Todos Comentarios Todos Comentarios



Nro. de control	Fecha	Edad	Peso	Talla	P. Cefálico	IMC	Observaciones

Todos Comentarios Todos Comentarios

MINISTERIO DE SALUD
C. DIAZ V.

MINISTERIO DE SALUD
M.C. JOSÉ ENRIQUE ALDANA CARRASCO

¿Cómo va mi desarrollo?

En esta sección está toda la información sobre cómo voy desarrollándome, es decir, cómo voy aprendiendo y adquiriendo habilidades para ser cada día más independiente y seguro de mí mismo.

Los hitos del desarrollo: son aquellas habilidades que se espera que un niño o niña logre en una determinada edad. Vigilar estos hitos permitirá saber si estoy desarrollándome bien y actuar a tiempo si hubiera algún problema.



Hitos del desarrollo psicomotor

ÁREA \ EDAD	Recién Nacido	3 meses	6 meses	9 meses	12 meses	18 meses	24 meses	30 meses
MOTOR GRUESO	Posición Fetal	Sostiene la cabeza	Se mantiene sentado	Se sienta	Camina	Corre		
MOTOR FINO	Hace Puño	Manos Abiertas	Transfiere	Coge con su mano completo	Coge con el dedo índice y pulgar			
SOCIAL	Mira	Sonríe - ríe	Abraza	Imita	Señala	Muestra	Juega	
COGNITIVO	Mira	Se interesa	Observa con atención	Busca	Voltea	Reconoce	Recuerda	Obedece
HABLA	Llora	Dice algo	Silabea	Balbucea	Señala	Parlotea	Frasea	Oraciones

Huanca, D. Guía de Vigilancia del Neurodesarrollo.

Señales de alerta en mi desarrollo



Si tienes alguna preocupación sobre mi desarrollo o ves alguna de las siguientes señales de alerta, por favor, consulta con el profesional de salud lo antes posible:

Busca mi edad en la parte de arriba o la edad menor más cercana a la mía, luego observa las señales en dirección hacia abajo.

	6 meses	9 meses	12 meses	18 meses	2 años	3 años	4 años	5 años	Cualquier edad
Socioemocional	No sonríe o grita en respuesta a los demás	No disfruta de las interacciones y el contacto visual y gestual con otros	No percibe la llegada de alguien nuevo No juega por turnos	No muestra interés por compartir e interactuar con los demás	Tira o golpea juguetes sin importar la función de los mismos	No imita **ni le interesa jugar** con otros **niños** Le cuesta **interpretar los sentimientos** propios y **ajenos**	Poco dispuesto a jugar colaborativamente	Juega diferente a los niños de su edad	No alcanza los hitos de desarrollo indicados Fuertes preocupaciones de los padres
Comunicación	No empieza a balbucear	No hace gestos No hace balbuceos de dos partes (ejem: ga ga)	No parlotea No responde a palabras familiares	No dice palabras claras No sigue indicaciones simples o cortas	No dice al menos 50 palabras No junta palabras No se entiende la mayor parte de lo que dice	No se **entiende** lo que **dice** No usa **oraciones** simples	No se entiende lo que dice No sigue indicaciones de 2 pasos	Dificultad para decir lo que está mal No responde preguntas	Significante pérdida de habilidades Falta de respuesta al sonido o estimulación visual
Motor Fino y Cognicion	No alcanza ni coge objetos Manos frecuentemente cerradas	No coge ni suelta objetos No pasa objetos de una mano a otra	La mayoría de la nutrición sigue siendo líquida/purés No puede masticar alimentos sólidos No hace pinza con índice y pulgar	No coge o garabatea con una crayola No intenta armar torre de bloques	No hay signos de autonomía motora gruesa y fina	No se **apoya a** sí mismo **para** valerse **por sí** solo Dificultad **para** coger **objetos** pequeños	Sigue usando pañal durante el día No puede dibujar líneas o círculos	Preocupación de docente por su aprendizaje No se viste ni come solo(a) No puede dibujar figuras simples	Pobre integración con adultos u otras niñas o niños. Diferencia entre lado derecho y izquierdo en cuestión de fuerza, movimiento o tono
Motor Grueso	No rueda No sostiene la cabeza u hombros cuando está boca abajo	No se sienta sin apoyo No se desplaza No soporta su peso en las piernas cuando es sostenido por un adulto	No se arrastra sobre su abdomen No jala para ponerse de pie No se para sosteniéndose de algún mueble	No trata de caminar sin apoyo No se para solo (sin apoyo)	No puede correr No sube escaleras No tira la pelota	No corre **bien** No sube **ni baja** escaleras No tira o **patea** la pelota No salta **en 2** pies	No pedalea No atrapa, lanza o patea la pelota No mantiene equilibrio cuando está en un pie	Camina, corre o sube escaleras de manera rara No manipula la pelota como sus pares No salta 5 veces en un mismo pie	Pérdida de movimiento flojo (de tono lento) o rígido y tenso (tono alto)

Adaptado de: Child Development Program, Children's Health Service, Queensland Government. The "Red Flag", Early Intervention Referral Guide for children 0 – 5 years.

Tamizaje del desarrollo

Es como una fotografía de mi desarrollo y permite saber si, en un determinado momento, estoy en riesgo.

Me harán un tamizaje del desarrollo a los 1, 6, 9, 18, 30, 42 y 60 meses y a cualquier edad si tú o el profesional de salud tienen alguna preocupación.

Edad	Fecha

¿Qué significan los resultados?

VERDE
Mi desarrollo ahora está dentro de lo esperado. **¡Vamos muy bien!** Sigue llevándome a mis controles de CRED.

AMARILLO
Requiero de tu apoyo para **mejorar** algunas de las habilidades esperadas. El profesional de salud te dará las pautas necesarias.

ROJO
Necesito una evaluación más profunda con un especialista que pueda **incentivar** más mi **desarrollo** y alcanzar las habilidades propias de mi edad.



¡Mamá, verifica con el profesional de salud el resultado de los tamizajes y **si** alguno es positivo!

¡Previniendo la anemia!

La anemia es la carencia de glóbulos rojos genera insuficiente oxigenación de las células y afecta el desarrollo cerebral y el rendimiento escolar en los niños.
Es clave EVITAR la ANEMIA, aun así, conociendo que tiene Tratamiento, por ello es importante una buena alimentación y la, suplementación preventiva.



¡Dame solo leche materna los primeros meses; y cuando inicie mi alimentación complementaria, desde los 6 meses!

¿Cómo se sabe si tengo anemia?

Es a través de MEDICION **DE HEMOGLOBINA** de acuerdo a la edad, el **profesional** de la salud te informará cuando **hacerlo**.



¿Cuándo debes darme los suplementos de hierro?

- ✓ 4 meses
- ✓ 6-59 meses de edad de acuerdo a esquema
- ✓ Si tu niña o niño es prematuro o nació con bajo peso al nacer desde los 30 días de vida.



¿Como puedes prevenir la anemia

Dame sólo leche materna los primeros meses e inicia mi alimentación complementaria desde los 6 meses. Incluye diariamente alimentos de origen animal como sangrecita, bazo, hígado, carnes rojas y pescado, ya que son las mejores fuentes de hierro.

Descarte de anemia	Medición de hemoglobina	Fecha de examen Edad Resultado
Tratamiento de anemia	Medicamento	Fecha de entrega Tipo de Sulf. de Fe.
	Exámenes de control	Fecha de examen Resultado
Suplementación preventiva con hierro	Gotas y jarabes	Edad Fecha de entrega Tipo de MN / SHO Edad Fecha de entrega Tipo de MN / SHO Edad Fecha de entrega Tipo de MN / SHO Edad Fecha de entrega Tipo de MN / SHO

¡Mamá y papá: algunos problemas en mi desarrollo pueden deberse a causas de mi salud. Es importante que me cuiden con mucho amor y responsabilidad !

Previniendo los parásitos



Puedes prevenir los parásitos cuando:

- Te lavas las manos y me lavas las manos antes y después de ir al baño, cambiarme los pañales, preparar los alimentos y comerlos.
- Hierves o cloras el agua antes de que la tome.
- Me das alimentos adecuadamente lavados y desinfectados.
- Me das carne bien cocida.
- No tenemos animales cerca de los alimentos.
- Pides un descarte parasitario al año y luego anualmente.
- Pides mi desparasitación profiláctica a partir de los 2 años, cada 6 meses.

Descarte de Parasitosis	Examen de seriado de heces	Fecha de examen Edad Resultado
	Test de Graham	Fecha de entrega Edad Resultado
Desparasitación profiláctica	Medicamento	Edad Fecha de entrega Tipo y dosis
		Edad Fecha de entrega Tipo y dosis

Suplementación preventiva con Vitamina A



Esta vitamina es muy importante para tener una buena visión, crecer saludable y tener buenas defensas ante virus y bacterias.
Consulta al profesional de salud cuándo me toca recibirla.

Edad				
Fecha de administración				
Edad				
Fecha de administración				

Cuidando mi alimentación

Antes de los 6 meses:

- Inicia la lactancia materna tan pronto como estemos juntos.
- Dame sólo leche materna durante los primeros 6 meses de edad a libre demanda. ¡Es la mejor defensa para mí y no cuesta!
- Asegura que reciba el calostro o primera leche para mejorar mis defensas.
- Ponte en una posición cómoda y aplica la técnica que te enseñaron para una mejor lactancia.
- Si te sientes agotada, busca apoyo de tu familia.

A partir de los 6 meses:

- Continúa con la lactancia materna desde los 6 meses hasta los 2 años o más, e introduce alimentos complementarios a partir de los 6 meses, ajustando la consistencia de los alimentos según la edad del niño y aumentando la cantidad de acuerdo a su desarrollo.
- Prioriza alimentos de origen animal, como hígado, carnes, pescado, huevo, y evita azúcares, sal y alimentos ultra procesados.
- Desde los 6 meses, incluye huevos, pescados, y frutas cítricas, y a partir de los 12 meses, añade leche, queso, y yogur.
- Mantén la suplementación de hierro para prevenir la anemia y fomenta el consumo de frutas y verduras locales.
- Durante enfermedades, ofrece comidas más frecuentes para asegurar una nutrición adecuada, e integra al niño en las comidas familiares.
- Dame frutas y verduras disponibles en nuestra localidad todos los días.
- Dame agua segura (hervida o clorada) siempre que lo necesite.
- Pon poca sal y azúcar en mis comidas y bebidas.



"Evita agregar azúcar a los alimentos y bebidas, retrasa al máximo el consumo de azucares hasta los dos años de edad".

"Dame mis alimentos en la mesa junto a mi familia, me gusta disfrutar de su compañía y me ayuda a sentirme seguro"

"Cuando compres alimentos, verifica si tienen estas etiquetas. Esto indica que no son saludables para mí.
EVITEMOS SU CONSUMO EN CASA



El Caminoo para el Buen Crecimiento

Mis acuerdos y compromisos



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dar sólo leche materna hasta los 6 meses. Continuar la lactancia materna hasta los 2 años.												
2	Dar comida tipo puré o papilla luego de los 6 meses.												
3	Darle alimentos de origen animal (sangrecita, bazo, higado, pescado, huevo) cada dia.												
4	Darle 3 comidas al día. A partir del mes 9 aumentar 1 o 2 refrigerios más.												
5	Darle medio plato de comida desde los 6 meses, aumentando a un plato al año de edad.												
6	Darle verduras y frutas todos los días												
7	Darle habas, frejoles, lentejas a su niño/niña.												
8	Darle gotas o jarabe de sulfato ferroso o micronutrientes.												
9	Lavarse las manos y las manos de la niña o niño.												
10	Animar a su hija o hijo a comer y hablarle cariñosamente												
11	Si el niño está enfermo, darle de comer más veces al día.												
12	Que la familia apoye con la alimentación de su hija o hijo.												
	¿Está creciendo bien? SI ○ NO ○												







Mis vacunas

Las vacunas son necesarias para estar protegido de enfermedades graves causadas por virus y bacterias. Cuando me vacunas, mi cuerpo genera defensas contra estos virus y bacterias para luchar contra la enfermedad en caso de que algún día entre en contacto con ese germen nocivo.



- **Las vacunas son muy seguras** y no afectarán mi desarrollo en absoluto.
- Vacunándome no sólo me proteges a mí sino a toda la familia y a **aquellos quienes tienen enfermedades graves.**
- Si tienes alguna pregunta sobre las vacunas, no dudes en consultar al profesional **de salud.**
- Sigue el siguiente esquema de vacunación del Perú para aseguramos que estoy protegido(a).



Esquema de Vacunación menor de 5 años

Vacunar a tu niña(o) es acto de amor.

BCG (TUBERCULOSIS) (RN)

HVB (ANTI - HEPATITIS)

ANTIPOLIO
1 dosis (2 meses) INY-IPV
2 dosis (4 meses) INY-IPV
3 dosis (6 meses) ORAL-APO

PENTAVALENTE (DPT + HIB + HVB)
1 dosis (2 meses)
2 dosis (4 meses)
3 DOSIS (6 meses)

NEUMOCOCO
1 dosis (2 meses)
2 dosis (4 meses)
3 dosis (12 meses)

ROTAVIRUS
1 dosis (2 meses)
2 dosis (4 meses)

INFLUENZA
1 dosis (6 meses)
2 dosis (7 meses)
2 dosis (7 meses)

SPR (SARAMPIÓN, PAPERA, RUBÉOLA)
1 dosis (12 meses)

VARICELA (Dosis única)

ANTIAMARILICA
15 meses

HVA (ANTI-HEPATITIS A)
15 meses

15 MESES 1REF DPT

1 ref. Antipolio (Oral 18 meses)

SPR (SARAMPIÓN, PAPERA y RUBÉOLA) 2 DOSIS

2AÑOS INFLUENZA (Dosis Anual)
3 AÑOS INFLUENZA (Dosis Anual)
4 AÑOS INFLUENZA (Dosis Anual)

2 ref. DPT
2 ref. Antipolio (oral)

Cuidando mi salud bucal

Las caries dentales son una de las enfermedades más prevalentes en la infancia y es totalmente evitable y prevenible.

- Empieza con mi higiene bucal antes de que broten mis primeros dientes y acude al odontólogo con regularidad.
- Cepilla mis dientes 2 veces al día como mínimo. Puedes usar la pasta dental familiar (1000 o 1500 PPM flúor), pero ten en cuenta colocar esta cantidad en su cepillo según su edad.
- Colócate detrás de la niña o niño en una posición que mantenga su cabeza apoyada en tu pecho.
- Levanta su labio superior para cepillar bien los dientes de esa zona Asegurarse que escupa todo el exceso de pasta dental, no enjuagar con agua.
- Cepilla los dientes como mínimo 2 veces al día.
- El cepillado nocturno es el más importante.
- Coloca la pasta dental en mi cepillo y ayúdame a cepillarme.



Señales de alto riesgo

Llévame de inmediato al puesto o centro de salud si:

- No lacto bien o me ahogo con la leche.
- Fiebre mayor a 38 grados que no cede con baños de agua tibia ni con paracetamol.
- Vómitos frecuentes.
- Muy adormecido, duermo mucho más de lo habitual o estoy inconsciente.
- Dificultad para respirar (respiración rápida y agitada, se hunde la piel entre las costillas).
- No puedo tomar líquidos con facilidad.
- Diarrea más de 10 veces al día o 4 veces en 4 horas de abundante cantidad.
- Mis labios o piel tienen una coloración azulada o morada.
- Convulsiones o temblor sin control.
- Llanto distinto al habitual (muy largo, muy corto o no se calma con nada).
- No respondo a ruidos fuertes.



Cuidando nuestra salud mental

Me desarrollo bien con tus cuidados y tu sensibilidad:



- Muéstrame tu afecto siempre. La calidez y la ternura me hacen sentir bien.
- Los masajes suaves me hacen sentir querido(a) y fortalecen mis músculos.
- Si sientes mucho cansancio o estrés, detente, respira hondo.
- Intenta calmarte antes de atenderme. Pide apoyo si es necesario.
- Los gestos y expresiones de mi cuerpo y el llanto son la forma de comunicarme en mis primeros meses. Aprende a reconocerlo.
- Mecerme, arrullarme y hablarme suave y rítmicamente me ayudará a calmarme.
- Siempre que debas salir, explícamelo y asegúrame que volverás para quedarme tranquilo(a) y seguro(a) al cuidado de otra persona.
- Cuando necesites corregirme, no me grites ni me pegues; háblame con suavidad y firmeza.

Estoy aprendiendo. No me dejes llorando porque eso afecta mi salud mental y física.

Recuerda,
Tan importante como comer o respirar es sentir confianza, seguridad y protección en ti.
Lo que me das ahora marcará mi futuro.



Promoviendo mi desarrollo

Me ayudas a desarrollarme mejor cuando:

- Me miras, **me sonríes** y me conversas mientras me cuidas.
- Respondes a los sonidos y **palabras que digo,** aunque todavía no sepa hablar.
- Aprovechas las actividades diarias para interactuar conmigo **y jugar.**
- **Juegas detrás de un pañuelo** para escondernos haciendo sonidos graciosos, tocando las narices o escondiendo objetos para que yo los encuentre.
- Tengo un espacio limpio y seguro para **jugar.**
- **Me lees cuentos** o me narras historias todos los días. Déjame pasar las páginas y mirar juntos los dibujos.
- **Elogias mi conducta** cuando es adecuada, esto me ayuda a aprender.
- Me dejas usar el vaso y la cuchara y **explorar** el sabor y textura de la comida.





Si tengo más de 5 años, sigue estas recomendaciones:

- No dejes de demostrarme afecto y **reconocer mis logros.**
- Ayúdame a asumir **pequeñas responsabilidades** en el hogar o la escuela; a respetar y ayudar a los demás.
- **Habla siempre conmigo** sobre los temas de la escuela, los amigos y las cosas que quiero hacer en el futuro.
- Ayúdame a tener metas alcanzables para **sentirme orgulloso** de mis logros.
- Enséñame a **ser paciente,** esperar mi turno y a terminar una tarea antes de ir a jugar.
- **Ponme reglas claras y respétalas.** Aliéntame a **resolver los problemas** y desacuerdos con otros niños.
- Hagamos **cosas divertidas en familia.** Sigue leyéndome y hagamos turnos para leer.
- **Controla** el tiempo frente a las pantallas.
- Usa la disciplina para guiarme y protegerme en lugar de usar castigos que me hagan sentir mal. **Explícame lo que debo hacer.**
- Elogia cuando tengo un buen comportamiento y **reconoce las cosas positivas.**
- Motívame a participar en **actividades grupales** y deportivas.
- Al crecer un poco más, ayúdame a **desarrollar mi sentido** de lo que está bien y lo que está mal.
- Dame alimentos ricos y nutritivos y **evita la comida chatarra** (golosinas, bebidas azucaradas, galletas y embutidos).
- Vigila que duerma el **tiempo suficiente (8 a 10 horas).**

MINISTERIO DE SALUD
C. DIAZ V.

MINISTERIO DE SALUD
C.C. JOSÉ EMILIO ALDANA CARRASCO
V°B°

Visita domiciliaria

En algunos casos se requiere que el personal de salud me visite en casa

Visita domiciliaria		
Fecha	Nombre	Observaciones e indicaciones

Sesiones de atención temprana

Fecha	Nombre	Observaciones e indicaciones

Otros servicios

Fecha	Hora	Servicio	Diagnóstico	Tratamiento/Procedimiento

Visita domiciliaria

En algunos casos se requiere que el personal de salud me visite en casa

Visita domiciliaria

Fecha Nombre Observaciones e indicaciones

Sesiones de atención temprana

Fecha Nombre Observaciones e indicaciones

Otros servicios

Fecha Hora Servicio Diagnóstico Tratamiento/Procedimiento

ANEXO N° 5 FICHA PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA

Propósito: Registrar de forma rápida y estandarizada el primer control del recién nacido través de la visita domiciliaria.

Identificación: Llene todos los datos del encabezado. El Documento Nacional de Identidad (DNI) del recién nacido (RN) es clave para su identificación en el sistema.

1. **Datos (Sección I):** Complete todos los campos con letra legible.
2. **Evaluación (Sección II):**
   - Realice la evaluación completa de los 3 componentes (RN, madre, entorno).
   - Marque (X) TODAS las opciones. No deje ítems en blanco.
   - NO describa la normalidad. La columna ***"Observaciones"*** se usa **ÚNICAMENTE** para anotar hallazgos de riesgo, alteraciones o detalles importantes que justifiquen una acción.

     Ejemplo: Si el cordón está limpio y seco, no escriba nada. ***Si tiene mal olor, anótelo en "Observaciones".***
3. **Plan de Acción (Sección III):**
   - Esta es la sección de decisión. Si durante la evaluación identificó **CUALQUIER signo de alarma**, la **acción descrita es un MANDATO, no una sugerencia.** Ejecute la acción y regístrela.
   - Si todo está normal, solo marque "No" y pase a la siguiente sección.
4. **Acuerdos y Cita (Sección IV):**
   - Anote máximo dos compromisos claros y factibles acordados con la familia.
   - Registre la fecha del segundo control, enfatizando que será en el establecimiento.

Recordatorio final: Esta ficha es un documento oficial. Su firma y sello validan la atención. La información debe ser transcrita o adjunta a la Historia Clínica.

FICHA PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA

I. DATOS DE LA VISITA Y DE IDENTIFICACIÓN

Fecha de la visita:	____/____/_____	**Hora de inicio:**	____:____	**Hora de término**	____:____
Profesional responsable:	_____	**DNI del recién nacido:**	_____	**Tipo de seguro:**	_____
Nombre del recién nacido:	_____	**Fecha de nacimiento:**	____/____/_____	**Sexo:**	[ ] M [ ] F
Nombre de la madre:	_____	**DNI de la madre:**	_____	**Edad de la madre:**	_____
Nombre del padre/cuidador principal:	_____	**Dirección del domicilio:**	_____ _____ _____	**Teléfono:**	_____

II. EVALUACIÓN INTEGRAL DEL RECIÉN NACIDO Y SU ENTORNO

Componente	Ítem de Verificación / Hallazgo	Observaciones / Detalles
A. EVALUACIÓN DEL RECIÉN NACIDO		
Observación general	[ ] Activo y reactivo [ ] Hipoactivo [ ] Irritable	_____
Respiración	[ ] Sin Dificultad [ ] Con Dificultad (taquipnea, quejido, etc.)	_____
Piel y mucosas	[ ] Rosada [ ] Pálida [ ] Cianosis. Ictericia: _____	_____

Termorregulación	[ ] Normotérmico [ ] Hipotérmico (piel fría)	_____
Cordón umbilical	[ ] Limpio y seco [ ] Con signos de onfalitis	_____
Alimentación	[ ] LME [ ] Succión vigorosa [ ] Dificultad para lactar	_____
Eliminación	N° Pañales mojados: ____ N° Deposiciones: ____	_____
Vacunas y tamizaje	BCG: [ ] Sí [ ] No HVB: [ ] Sí [ ] No T. Neonatal: [ ] Sí [ ] No	_____
B. EVALUACIÓN DE LA MADRE		
Bienestar emocional	[ ] Sin alteraciones [ ] Signos de tristeza/ansiedad.	_____
Lactancia	[ ] Sin dificultad [ ] Con dolor o dificultad.	_____
Red de apoyo	[ ] Cuenta con red de apoyo activa dentro de su hogar, centro laboral.	_____
C. EVALUACIÓN DEL ENTORNO Y PRÁCTICAS DE CUIDADO		
Entorno del sueño (**verificación de sueño seguro**)	[ ] Posición: Duerme boca arriba (correcto). [ ] Superficie: Firme y plana (correcto). [ ] Espacio: Despejado, sin objetos blandos (correcto). [ ] Ubicación: Cuna/espacio propio (correcto). **Observar Riesgos:** [ ] Duerme boca abajo/costado [ ] Colecho inseguro.	_____
Higiene y saneamiento	[ ] Condiciones adecuadas [ ] Condiciones de riesgo.	_____
Vínculo e interacción	[ ] Se observa vínculo positivo.	_____
Signos de peligro	[ ] Familia los identifica [ ] No los identifica.	_____

III. PLAN DE ACCIÓN Y MANEJO DE HALLAZGOS

Hallazgo / Signo de Alarma Identificado	Acción Inmediata Obligatoria
RN con dificultad respiratoria, cianosis, convulsiones, hipotermia o hipoactividad severa.	**ACTIVAR REFERENCIA INMEDIATA Y ASISTIDA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (EESS) DE MAYOR COMPLEJIDAD.**
RN con ictericia que se extiende por debajo del ombligo.	Gestionar referencia para evaluación médica en < 24h.
RN con signos de onfalitis o succión débil persistente.	Gestionar referencia para evaluación médica.
Madre con signos de tristeza o ansiedad persistente.	Gestionar interconsulta.
Prácticas de sueño inseguro, lactancia, entre otros o vacunas/tamizajes pendientes.	Realizar consejería y demostración.

IV. INTERVENCIONES, ACUERDOS Y PRÓXIMA CITA

Intervenciones realizadas en la visita:

1. _____
2. _____

Acuerdos y compromisos con la familia:

1. _____
2. _____

Próxima Cita (2° Control CRED):

Fecha: ____/____/_____ **Lugar:** Establecimiento de salud_____

_____
Firma y sello del profesional de la salud

ANEXO N° 6: FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN[1]

- **Propósito:** Estandarizar la identificación y reevaluación continua de los factores de riesgo y protección. Este instrumento es la base para decidir la implementación de un control de CRED diferenciado.
- **Aplicación**: Se completa en el primer control y se actualiza obligatoriamente en cada control subsecuente.
- **Marcado:** Marque "SÍ" si el factor (sea de riesgo o de protección) está presente.
- **Acción**: La presencia de uno o más factores de riesgo ("SÍ") o la ausencia de factores de protección clave ("NO") requiere que usted implemente un control de CRED diferenciado.
- **Registro:** El factor identificado debe registrarse en la Historia Clínica

I. FACTORES DE RIESGO (Marcar "SÍ" si está presente)	SÍ	NO
A. INDIVIDUALES / BIOLÓGICOS		
1. Madre adolescente (menor de 16 años).	[ ]	[ ]
2. Asistencia a dos o menos consultas prenatales.	[ ]	[ ]
3. Bajo peso al nacer (<2500 g) y/o prematuridad.	[ ]	[ ]
4. Apgar menor de 7 al nacer.	[ ]	[ ]
5. Anomalía congénita.	[ ]	[ ]
6. Morbilidad neonatal severa (hipoglicemia, sepsis, meningitis, ictericia patológica).	[ ]	[ ]
7. Examen neurológico alterado.	[ ]	[ ]
8. Antecedente de trauma obstétrico o enfermedad materna perinatal.	[ ]	[ ]
Otras condiciones de riesgo (post-neonatales):		
9. Daño cerebral, malformación del Sistema Nervioso Central, Neuro-metabolopatía, cromosomopatía o síndrome dismórfico.	[ ]	[ ]
10. Infecciones en el periodo prenatal.	[ ]	[ ]
11. Presencia de discapacidad física.	[ ]	[ ]
12. Presencia de enfermedad crónica o desnutrición.	[ ]	[ ]
13. Infecciones recurrentes durante la infancia.	[ ]	[ ]
B. FAMILIARES		
14. Hijo de madre con patología mental (depresión, trastornos psicóticos).	[ ]	[ ]

[1]Adaptado de:

- Curso Taller para la Prevención de Discapacidad Infantil | Caja de Herramientas [Internet]. [citado 8 de septiembre de 2020]. Disponible en: http://app.inr.gob.pe/cajaherramientas/curso-taller-para-la-prevencion-de-discapacidad-infantil/
- Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención, Temprana. Libro Blanco de la Atención Temprana [Internet]. Real Patronato sobre Discapacidad; 2005 [citado 10 de octubre de 2019]. Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/doc/LibroBlancoAtenci%C2%A6nTemprana.pdf
- Fallon B, Filippelli J, Joh-Carnella N, Milne E, Carradine J. Promoting Protective Factors in Environments of Risk for Young Children: An Organizing Framework for Practice, Policy, and Research. Gender and the Genome. October 2018:96-110. doi:10.1177/2470289718820843

15. Hermanos con patología neurológica no aclarada.	[ ]	[ ]
C. MEDIOAMBIENTALES		
16. Exposición a metales pesados o sustancias químicas.	[ ]	[ ]
D. PSICOSOCIALES		
17. Subestimulación severa o deprivación afectiva severa.	[ ]	[ ]
18. Maltrato o violencia doméstica.	[ ]	[ ]
19. Negligencia en el cuidado.	[ ]	[ ]
20. Niño(a) en abandono o en proceso de adopción.	[ ]	[ ]
21. Interacciones inadecuadas con el cuidador principal.	[ ]	[ ]
22. Niño(a) en situación de institucionalización.	[ ]	[ ]
23. Falta de afecto.	[ ]	[ ]
24. Pobreza extrema.	[ ]	[ ]
25. Bajo nivel educativo parental (especialmente materno).	[ ]	[ ]
26. Embarazo accidental traumatizante (violación).	[ ]	[ ]
27. Convivencia conflictiva en el núcleo familiar.	[ ]	[ ]
28. Padres con bajo coeficiente de inteligencia y entorno no estimulante.	[ ]	[ ]
29. Alcoholismo/drogadicción parental.	[ ]	[ ]
30. Prostitución, delincuencia o encarcelamiento en el entorno familiar.	[ ]	[ ]
33. Cualquier otra consideración del profesional de la salud.	[ ]	[ ]

II. FACTORES DE PROTECCIÓN (Marcar "SÍ" si está presente)	**SÍ**	**NO**
1. Buen estado de salud física del niño a término.	[ ]	[ ]
2. Madre, padre o cuidador principal con adecuado estado de salud mental.	[ ]	[ ]
3. Lactancia materna establecida.	[ ]	[ ]
4. Entorno familiar de protección y seguridad.	[ ]	[ ]
5. Apego seguro con la madre, padre o cuidador principal.	[ ]	[ ]
6. Relaciones cercanas y cálidas con los adultos principales.	[ ]	[ ]
7. Oportunidades de juego y comunicación.	[ ]	[ ]
8. Ausencia de castigo físico y maltrato.	[ ]	[ ]
9. Madre, padre o cuidador principal con soporte familiar y social.	[ ]	[ ]
10. Percepción de pertenencia a la cultura.	[ ]	[ ]

ANEXO N° 7: GUÍA PARA EL EXAMEN FÍSICO [2]

1. GENERALIDADES:

Antes de iniciar cualquier contacto con el niño, el profesional de la salud asegura obligatoriamente las siguientes condiciones para garantizar la calidad, seguridad y humanización de la atención:

- **Bioseguridad:** Realizar un correcto lavado de manos.
- **Ambiente:** Garantizar un entorno limpio, con confort térmico, libre de corrientes de aire y que preserve la privacidad.
- **Comunicación:** Explicar al niño, la madre, padre o cuidador principal el procedimiento a realizar de forma clara y sencilla, obteniendo su colaboración.
- **Posicionamiento**: Realizar el examen en una superficie segura y cómoda (camilla, colchoneta) o, preferiblemente, en el regazo o brazos del cuidador para maximizar la tranquilidad del niño.

2. EXAMEN FÍSICO GENERAL: El examen se realiza de forma sistemática, siguiendo el orden céfalo-caudal/próximo-distal.

EXAMEN FÍSICO		SIGNOS DE ALARMA A DESCARTAR
GENERAL	– Observar vínculo cuidador-niño, estado de alerta, actividad, higiene. – Medir y valorar signos vitales según edad (Ver numeral 12. VALORES NORMALES DE SIGNOS VITALES del presente Anexo).	Letargo, irritabilidad persistente, descuido.
PIEL Y FANERAS (CABELLO, UÑAS)	– Evaluar color (ictericia, palidez), hidratación, turgencia. – Buscar activamente lesiones (eritemas, pápulas, equimosis). – Evaluar distribución y textura del cabello; color y forma de las uñas.	Deshidratación, palidez/ictericia severa, lesiones sospechosas de violencia.
CABEZA Y CUELLO	– Evaluar forma y simetría del cráneo. – Palpar suturas y fontanelas (tamaño, tensión). – Medir perímetro cefálico y graficar (hasta los 60 meses). – Evaluar movilidad del cuello, buscar masas o tortícolis.	Fontanela abombada/deprimida, craneosinostosis, micro/macrocefalia.

[2] Todo examen físico debe incluir siempre la valoración de signos y síntomas de cáncer y lesiones indicadoras de maltrato físico de acuerdo con lo descrito en las secciones correspondientes.
[2] https://www.paho.org/sites/default/files/2023-07/2019-tabla-presion-arterial-signos-vitales-1-18-anos.pdf

CARA	– Ojos: Ubicación, alineación, opacidades. – Nariz: Permeabilidad, secreciones, deformidades. – Boca: Frenillos, paladar, estado dental. – Oídos: Pabellones auriculares, conducto auditivo.	Asimetrías faciales, opacidad corneal, caries.
TÓRAX Y CARDIO-PULMONAR	– Observar simetría, deformidades (pectus excavatum). – Evaluar patrón respiratorio, buscar tirajes. – Auscultar campos pulmonares y ruidos cardíacos (soplos, ritmo).	Dificultad respiratoria, sibilantes, soplos cardíacos.
ABDOMEN	– Observar forma (distendido/excavado), motilidad. – Palpar protuberancia umbilical, buscar hernias, masas o visceromegalias. – Auscultar ruidos hidroaéreos. – En recién nacidos (RN), verificar cordón umbilical (descartar onfalitis).	Distensión abdominal significativa, masas palpables, signos de onfalitis.
COLUMNA VERTEBRAL Y EXTREMIDADES	– Evaluar alineación de la columna, buscar fositas o masas. – Evaluar simetría, movilidad, tono muscular y fuerza. – Valoración de cadera y marcha.	Asimetría de pliegues, limitación de la abducción.
GENITOURINARIO Y ANAL	– Observar anatomía externa, higiene y secreciones. – **En niñas:** Descartar sinequia de labios. – **En niños:** Palpar testículos (descartar criptorquidia), evaluar prepucio (fimosis), ubicación del meato. – Verificar permeabilidad anal y buscar fisuras.	Genitales ambiguos, criptorquidia, hipospadias, ano imperforado.

3. EXAMEN NEUROLÓGICO

- **Propósito**: La detección precoz de posibles desviaciones o signos de alarma en el neurodesarrollo.
- **Metodología:** El examen combina la observación del comportamiento espontáneo con la exploración directa de reflejos primarios y tono muscular.

a. Valoración funcional (entrevista y observación): El profesional de la salud indaga con la madre, padre o cuidador principal y observa activamente los siguientes aspectos.

COMPONENTE A EVALUAR	HALLAZGOS NORMALES ESPERADOS / PUNTOS DE VERIFICACIÓN	SIGNOS DE ALARMA
1. Estado de alerta y comportamiento	Abre los ojos espontáneamente, reacciona a estímulos, interactúa.	Letargo, somnolencia excesiva, irritabilidad persistente.

2. Movilidad espontánea del cuerpo[3]	Movimientos de las cuatro extremidades simétricos y fluidos. Postura y actitud acordes a la edad.	Asimetría en los movimientos, hipoactividad marcada, posturas fijas.
3. Movilidad de ojos y expresión facial[4]	Movimientos faciales y linguales simétricos. Sigue objetos con la mirada (según edad).	Asimetría facial, ausencia de seguimiento visual después de los 3 meses.
4. Perímetro cefálico y cráneo[5]	Perímetro cefálico entre +2 y -2 DE. Fontanelas normotensas.	Perímetro por fuera de rangos, fontanela abombada o deprimida.
5. Tono muscular pasivo y activo	Tono muscular adecuado, sin hipertonía (rigidez) o hipotonía (flacidez) significativa.	"Bebé de trapo" (hipotonía severa), rigidez excesiva.
6. Sostén cefálico y de tronco	Sostiene la cabeza a los 3 meses. Logra la posición de mantenerse sentado a los 6 meses y sentado sin apoyo a los 8-9 meses.	Ausencia de sostén cefálico a los 4 meses, no se mantiene sentado a los 8 meses.
7. Bipedestación, marcha y fuerza muscular	Se para con apoyo a los 9 -10 meses. Camina solo entre los 12 y 16 meses. A partir de los 16 meses, se observa fuerza y ejecución adecuada del movimiento.	No se para con apoyo a los 12 meses, no camina solo a los 18 meses. Debilidad evidente o asimétrica.

b. Examen de reflejos primitivos y reacciones posturales: El profesional evalúa la presencia, simetría y correcta desaparición de los siguientes reflejos. La ausencia, asimetría o persistencia de un reflejo más allá de su edad de desaparición constituye un signo de alarma que obliga a la interconsulta o derivación.

REFLEJO / REACCIÓN	PROCEDIMIENTO DE ELICITACIÓN	EDAD DE APARICIÓN	EDAD DE DESAPARICIÓN
MARCHA AUTOMÁTICA	Se sostiene al bebé sujetándolo por el tronco y se le desciende hasta que los pies estén en contacto con una superficie plana, provocando que avance con movimientos coordinados.	34 semanas de gestación	Sexto mes de vida
PRENSIÓN PALMAR	Se coloca el dedo índice en la palma de la mano del niño y se ejerce una ligera presión. La respuesta es la flexión de los dedos.	28 semanas de gestación	Quinto mes de vida

[3] Primer ítem de exploración neurológica de la prueba EDI.
[4] Segundo ítem de exploración neurológica de la prueba EDI.
[5] Tercer ítem de exploración neurológica de la prueba EDI.

REFLEJO DE MORO	Se provoca mediante un ruido súbito o simulando una caída hacia atrás. El bebé reaccionará con un sobresalto, extendiendo brazos y piernas.	32 semanas de gestación	Sexto mes de vida
REFLEJO TÓNICO ASIMÉTRICO DE CUELLO	En posición de cúbito supino, se gira la cabeza del bebé hacia un lado. El brazo y la pierna del lado facial se extienden, mientras los contralaterales se flexionan.	36 semanas de gestación	Cuarto mes de vida
REFLEJO DE GALANT	Con el bebé en cúbito ventral, se roza con el dedo los lados de la columna, desde las vértebras cervicales hasta el coxis. La respuesta es la curvación de la columna hacia el lado estimulado.	24 semanas de gestación	Cuarto mes de vida
PRENSIÓN PLANTAR	Se presiona con el dedo la zona de la planta del pie, inmediatamente por debajo de los dedos. La respuesta es la flexión de los dedos del pie.	30 semanas de gestación	Décimo mes de vida
REACCIÓN A LA PROPULSIÓN LATERAL DEL TRONCO	En posición sentado, se aplica un gentil empujón lateral a la altura del hombro. El niño extiende el brazo del lado opuesto para parar la caída.	Sexto mes de vida	Noveno mes de vida
REACCIÓN DE PARACAÍDAS	Se sostiene al niño en posición erguida y se rota su cuerpo rápidamente hacia adelante, como si se cayera. El niño reacciona extendiendo los brazos para interrumpir la caída.	Séptimo mes de vida	Décimo mes de vida

4. EVALUACIÓN OCULAR Y TAMIZAJE VISUAL

- **Propósito:** Detección precoz de problemas o deficiencias visuales.
- **Metodología:** Combina la identificación de factores de riesgo, la inspección directa de estructuras oculares, la exploración de reflejos y la medición funcional de la agudeza visual.

a. Identificación de factores de riesgo ocular (anamnesis)

El profesional indaga y consigna obligatoriamente la presencia de cualquiera de los siguientes factores de riesgo. La presencia de uno o más de ellos requiere un monitoreo más cercano y puede justificar una referencia al especialista incluso con un examen físico normal.